气滞证诊断标准

编制说明

提 出　单 位：暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学
归 口　单 位：中华中医药学会
主要起草单位：暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学
主要 起 草人：陈家旭、胡志希、李先涛、郭蓉娟、杨小波

二〇二二年〇五月

目录

一、工作简况 1
二、标准的编制原则和关键技术内容 1
三、主要工作过程 2
（一）提案、申请、立项 2
（二）成立标准起草组 2
（三）确定标准的题目和范围 5
（四）构建标准问题 6
（五）文献检索 6
（六）临床调研 28
（七）达成共识 48
（八）撰写标准草案 50
（九）征求意见 51
四、与国内外同类标准的对比和最新标准采用情况 56
五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系 56
六、代表性分歧意见的处理经过和依据 56
七、宣传、贯彻标准和后效评价标准的要求和措施 56
八、废止现行有关标准的建议 57
九、相关附录 57
附件 1 《气滞证诊断标准》立项公告 59
附件 2 《气滞证及其亚型证诊断标准》第一轮德尔菲专家问卷 60
附件 3 《气滞证及其亚型证诊断标准》第二轮德尔菲专家问卷 71
附件 4 《气滞证及其亚型证诊断标准》第三轮德尔菲专家问卷 76
附件 5 《气滞证及其亚型证诊断标准》层次分析法问卷 81
附件 6 历次会议纪要 91

气滞证诊断标准编制说明

一、工作简况

1.任务背景

气滞证是中医临床常见证候之一，多见于许多重大疾病和慢性疾病，并为其始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准缺如，严重影响了证候诊断的规范性、一致性及可重复性。主要有以下几点问题：未建立科学的量化标准，临床诊断效能及实用性有待考证；不同疾病气滞证主次症状、条目权重、诊断阈值尚未确定。为避免个人因素对辨证的干扰，提高临床诊疗和临床科研辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床与科研气滞证辨证的准确性和规范性。

为落实《中医药发展战略规划纲要（2016—2030 年）》提出的“健全中医药法律体系和标准体系”的重要任务，本标准相关法律法规和技术文件指导的框架下，综合运用文献系统评价、德尔菲法、层次分析法、专家访谈、诊断性试验等方法，确立了气滞证诊断条目及其权重，修订了气滞证相关诊断标准，为气滞证的临床诊疗和科学研究提供指导。

2.任务来源

本任务来源于广东省重点领域研发计划项目“气滞证辨证标准的系统研究”（项目编号：2020B1111100001）的工作基础上开展相关研究工作，由暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学负责组织完成。立项时间是 2020 年 3 月。课题经费资助来自广东省重点领域研发计划项目。

3. 标准起草单位

参与起草单位包括：暨南大学、湖南中医药大学、广州中医药大学、北京中医药大学、广东省中医院、湖南中医药大学第一附属医院、湖南省脑科医院、暨南大学附属第一医院、广州中医药大学第二附属医院、广州市惠爱医院、佛山市第三人民医院。

二、标准的编制原则和关键技术内容

1.标准的编制依据和原则

本标准按照《中华中医药学会中医标准制定的技术方案》、《标准化工作导则

标准的结构和编写 GB/T1.1-2009》规定的规则撰写。

本标准编制遵循“开放性、协商一致性、透明性、可追溯性”原则，按照“能够为中医行业内实际应用，能被行业外广泛接受和认可，并与国际诊疗标准接轨”的要求，开展了气滞证诊断标准的研究。

2.标准的关键技术内容

《气滞证诊断标准》共有 8 部分组成，分别是：前言、引言、范围、规范性引用文件、术语及定义、气滞证的诊断标准、附录 A（资料性附录）历年气滞证类中医辨证标准的相关部分、参考文献。

三、主要工作过程

（一）提案、申请、立项

2020 年 04 月 17 日，陈家旭教授在腾讯会议召开“气滞证诊断标准”项目讨论会，会议确定向中华中医药学会标准化办公室申请《气滞证诊断标准》的立项，并确立了由总指导、临床医师、方法学专家、科研协作组共同构成起草组。2020 年 05 月底向中华中医药学会标准化办公室提交《气滞证诊断标准》立项申请材料。2020 年 08 月，中华中医药学会组织召开团体标准立项函评，《气滞证诊断标准》通过立项论证。会后按照专家意见对立项申请书进行完善，经中华中医药学会秘书长办公会审议批准，于 2020 年 11 月 16 日发文正式立项（附件 1：中华中医药学会团体标准立项公告）。

（二）成立标准起草组

1.标准起草组成立方式

通过负责人召集的方式确定项目组成员，于 2021 年 4 月 26 日线上会议成立项目组。

2.标准起草组组成情况

（1）标准起草组组成情况

起草单位分别有暨南大学、广州中医药大学、北京中医药大学东方医院、上海中医药大学、湖北中医药大学、安徽中医药大学、广西中医药大学附属瑞康医院、湖南中医药大学、中山大学第一附属医院、广东省中医院、惠爱医院、华侨医院、湖南中医药大学第一附属医院、湖南省脑科医院；单位级别分别来自高等

教育学校、三级甲等医院、二级甲等医院；专业领域分别为中医诊断学、中医神志病、心脑血管疾病、中医药信息学、中西医结合肝病、脾胃病科等；职称分别为教授、主任医师、副主任医师。

（2）标准起草组成员名单及分工

以表格形式列出，见表 1。

表 1 标准起草组成员及其工作内容

序号	姓名	单位	职称	专业	学位	工作内容
1	陈家旭	暨南大学	教授	中医诊断学	博士	指导标准工作、确定标准计划、编写标准草案
2	胡志希	湖南中医药大学	教授	中医诊断学，心脑血管疾病	博士	指导标准工作、确定标准计划、编写标准草案
3	李先涛	广州中医药大学	教授	中医证候，心脑血管疾病	博士	指导标准工作、确定标准计划、编写标准草案
4	郭蓉娟	北京中医药大学东方医院	教授	中医药治疗神经系统疾病的基础与临床	博士	指导标准工作、确定标准计划、编写标准草案
5	杨小波	广东省中医院	主任医师	证候基础研究	博士	指导标准工作、确定标准计划、编写标准草案
6	王忆勤	上海中医药大学	教授	中医诊断学	博士	确定标准计划、参与技术工作
7	邹小娟	湖北中医药大学	教授	中医诊断学	本科	确定标准计划、参与技术工作
8	董昌武	安徽中医药大学	教授	中医诊断学/中医四诊信息化及证候基础研究	博士	确定标准计划、参与技术工作
9	何建成	上海中医药大学	教授	中医诊断学	博士	确定标准计划、参与技术工作
10	郑景辉	广西中医药大学附属瑞康医院	教授	中西医结合心血管疾病的防治研究	博士	确定标准计划、参与技术工作
11	李新纯	湖南省脑科医院	主任医师	精神心理科	硕士	确定标准计划、参与技术工作
12	刘建和	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	心血管科	博士	确定标准计划、参与技术工作
13	简维雄	湖南中医药大学	教授	心病证治机理研究	博士	确定标准计划、参与技术工作
14	刘旺华	湖南中医药大学	教授	中医诊断学，病证规范化研究	博士	确定标准计划、参与技术工作
15	丁长松	湖南中医药大学	教授	统计学	博士	确定标准计划、参与技术工作
16	喻斌	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	脾胃病	硕士	确定标准计划、参与技术工作

17	张涛	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	肝病	博士	确定标准计划、参与技术工作
18	陈新林	广州中医药大学	教授	卫生统计学	博士	确定标准计划、参与技术工作
19	张诗军	中山大学第一附属医院	主任医师	肝病	博士	确定标准计划、参与技术工作
20	黄绍刚	广东省中医院	主任医师	脾胃病	博士	确定标准计划、参与技术工作
21	刘赟	惠爱医院	副主任医师	中医神志病	博士	确定标准计划、参与技术工作
22	朱志敏	惠爱医院	副主任医师	中医神志病	硕士	确定标准计划、参与技术工作
23	钟舒明	华侨医院	副主任医师	精神心理科	博士	确定标准计划、参与技术工作
24	李艳	广东省中医院	主任医师	精神心理科	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
25	陈孝银	暨南大学	教授	证候规范化研究	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
26	方朝义	河北中医学院	教授	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
27	黎雪松	佛山市第三人民医院	教授	精神心理科	学士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
28	葛鑫宇	广州市惠爱医院	副教授	精神心理科	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
29	王颖	暨南大学第一附属医院	研究员	脾胃病	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
30	周旋	暨南大学	讲师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
31	马庆宇	暨南大学	讲师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
32	李晓娟	暨南大学	副教授	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
33	梁昊	湖南中医药大学	副教授	统计学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
34	胡思远	湖南中医药大学	讲师	统计学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
35	李琳	湖南中医药大学	讲师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
36	方格	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
37	范星宇	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
38	廖晓倩	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
39	谭朵廷	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
40	胡慧玲	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿

41	蒋浩波	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
42	廉坤	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
43	谈宇权	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
44	张君宇	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
45	邱宏	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
46	黄淑敏	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
47	熊霞军	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
48	周耀	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
49	雷经纬	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
50	藏秋池	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
51	王啸轶	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
52	陈明远	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	硕士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
53	钟森杰	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
54	王梓仪	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿
55	张倩	湖南中医药大学	医师	中医诊断学	博士	形成标准初稿、确定标准送审稿和报批稿

3. 利益冲突声明

本标准所有参与成员均无利益冲突。

（三）确定标准的题目和范围

方法：根据广东省重点领域研发计划项目“气滞证辨证标准的系统研究”（项目编号：2020B1111100001）明确题目气滞证诊断标准。

过程：中医气滞证涉及健康/亚健康人群及疾病人群，其中疾病人群涉及疾病谱广（如抑郁症、慢性非萎缩性胃炎、围绝经期综合征、乳腺纤维腺瘤、冠心病、慢性阻塞性肺疾病等），临床患者人群量大。为建立简单易行、实用性强的中医气滞证共性诊断标准；通过现代文献、临床实践中，探索病位肝、胃肠、心、肺四个亚型证个性症状、体征，从而提高临床辨证的准确性，从而提高临床疗效，且受益群体众多，具有重要价值和意义。

（四）构建标准问题

建立科学的气滞证量化标准，临床诊断效能；明确不同疾病气滞证主次症状、条目权重、诊断阈值。为避免个人因素对辨证的干扰，提高临床诊疗和临床科研辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床与科研关于气滞证辨证的准确性和规范性。

（五）文献检索

1.证据检索

1.1 检索方法

检索文献1989年1月1日至2020年7月30日中国期刊全文数据库（CNKI）、万方数据资源系统（Wanfang）、中国生物医学文献数据库（SinoMed)维普数据库（VIP）数据库。

1.1.1 中文数据库检索式

①肝郁气滞证

1）“抑郁症”或“围绝经期综合征”或“乳腺癌”“2）“郁证”或“郁病”或“绝经前后诸证”或“乳岩”3）肝郁气滞证”或“肝气郁结证” 或“肝气郁滞证”； 4）#1 OR #2 AND#3。

②胃肠气滞证

1）“慢性非萎缩性胃炎”或“慢性浅表性胃炎”或“便秘”或“肠易激综合征”；2）“胃脘痛”或“胃痞”或“嘈杂”或“便秘”或“腹痛”或“泄泻”或“郁证”；3） “胃肠气滞证”或“胃脘气滞证”或“气郁脘痛”或“肠道气滞证”或“小肠气滞证”；4)#1 OR#2 AND#3。

③心脉气滞证

1）“冠心病”或“冠状动脉粥样硬化下心脏病”或“冠状动脉性心脏病”或“高血压”或“心律失常”或“心肌炎”；2）“胸痹”或“真心痛”或“眩晕”或“头痛”或“心悸”或“怔忡”；3）“心脉气滞证”或“气滞心脉证”或“气滞心胸证”；4)#1 OR#2 AND#3。

④肺气郁滞证

1）“慢性阻塞性肺疾病”或“肺炎”或“慢性支气管炎”或“支气管哮喘”；2）“咳嗽”或“喘证”或“肺胀”或“哮病”或“气胸”；3）“肺气郁滞证”或“气郁伤肺证”或“气郁肺证”或“肺气郁滞证”或“肺气郁痹证”；4）#1 OR#2 AND#3。

1.1.2 英文数据库检索式

①肝郁气滞证

1) "Depression" or "perimenopausal syndrome" or "breast cancer", "2)" depression syndrome "or" depression disease "or" premenopausal and postmenopausal syndrome "or" milk rock "3) liver qi stagnation syndrome" or "liver qi stagnation syndrome" or "liver qi stagnation syndrome"; 4）#1 OR #2 AND#3.

②胃肠气滞证

1) "chronic non-atrophic gastritis" or "chronic superficial gastritis" or "constipation" or "irritable bowel syndrome"; 2) "epigastric pain" or "stomach ruffian" or "noisy" or "constipation" Or "abdominal pain" or "diarrhea" or "stagnation syndrome"; 3) Syndrome type: "gastrointestinal qi stagnation syndrome" or "stomach qi stagnation syndrome" or "qi stagnation and epigastric pain" or "intestinal qi stagnation syndrome" Or "Small Intestine Qi Stagnation"; 4)#1 OR#2 AND#3.

③心脉气滞证

1) "coronary heart disease" or "heart disease under coronary atherosclerosis" or "coronary heart disease" or "hypertension" or "arrhythmia" or "myocarditis"; 2) Chinese medicine name of disease: "chest paralysis" or "True pain" or "dizziness" or "headache" or "heart palpitations" or "palpitation"; 3) Syndrome type: "Heart qi stagnation syndrome" or "Qi stagnation heart pulse syndrome" or "Qi stagnation cardiothoracic syndrome"; 4)#1 OR#2 AND#3.

④肺气郁滞证

1) "chronic obstructive pulmonary disease" or "pneumonia" or "chronic bronchitis" or "bronchial asthma"; 2) "cough" or "asthma" or "lung bloating" or "asthma" or "pneumothorax"; 3) "Lung qi stagnation syndrome" or "Qi stagnation damages the lung syndrome" or "Qi stagnation lung syndrome" or "Lung qi stagnation syndrome" or "Lung qi stagnation syndrome"; 4) #1 OR#2 AND# 3.

1.2 检索结果

列出检索到的文献总量及每个数据库的检索到的文献数量。

①肝郁气滞证

文献检索：中国知网数据库（CNKI）281 篇、万方数据资源系统（Wanfang）142 篇、维普数据库（VIP）34 篇、中国生物医学文献数据库（SinoMed)34 篇，共 491 篇文献。专著检索：67 本书籍。

②胃肠气滞证

文献检索：中国知网数据库（CNKI）2697 篇、万方数据资源系统（Wanfang）8651 篇、维普数据库（VIP）558 篇、中国生物医学文献数据库（SinoMed)2090 篇，共 13996 篇文献。专著检索：161 本书籍。

③心脉气滞证

文献检索：中国知网数据库（CNKI）5701 篇、万方数据资源系统（Wanfang）3829 篇、维普数据库（VIP）486 篇、中国生物医学文献数据库（SinoMed)1871 篇，共 11887 篇文献。专著检索：34 本书籍。

④肺气郁滞证

文献检索：中国知网数据库（CNKI）179 篇、万方数据资源系统（Wanfang）1121 篇、维普数据库（VIP）27 篇、中国生物医学文献数据库（SinoMed)297 篇，共 1624 篇文献。专著检索：25 本书籍。

2.证据筛选和资料提取

（1）证据筛选和资料提取方法

①肝郁气滞证

去重后剩余剩 424 篇文献，阅读题目摘要、文献、纳入标准及排除标准，剩余 98 篇文献和 49 本书籍。

②胃肠气滞证

去重后剩余 11567 篇文献，阅读题目摘要、文献、纳入标准及排除标准，剩余 58 篇文献和 62 本书籍。

③心脉气滞证

去重后剩余 10587 篇文献，阅读题目摘要、文献、纳入标准及排除标准，剩余 70 篇文献和 25 本书籍。

④肺气郁滞证

去重后剩余 1387 篇文献，阅读题目摘要、文献、纳入标准及排除标准，剩余 38 篇文献和 13 本书籍。

（2）纳入排除标准

纳入标准：参考气滞证相关诊断标准、共识等的文献；未参考诊断标准，但有涉及气滞证类，并显示其症状、体征、舌象和脉象的临床表征文献。

排除标准：关于气滞证的复合证的文献；未明确气滞证类的文献；相兼证型

中气滞证类不是主证的文献；动物实验类文献；综述类文献；一稿多投的文献等。

（3）证据筛选流程及结果

①肝郁气滞证

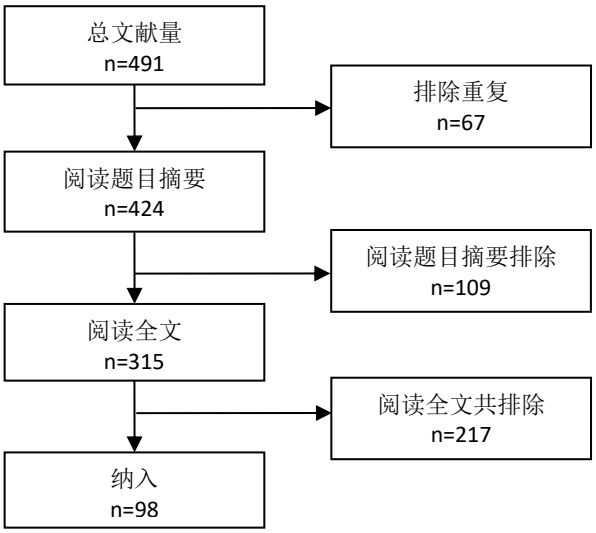

图 1 肝郁气滞证证据筛选流程图

②胃肠气滞证

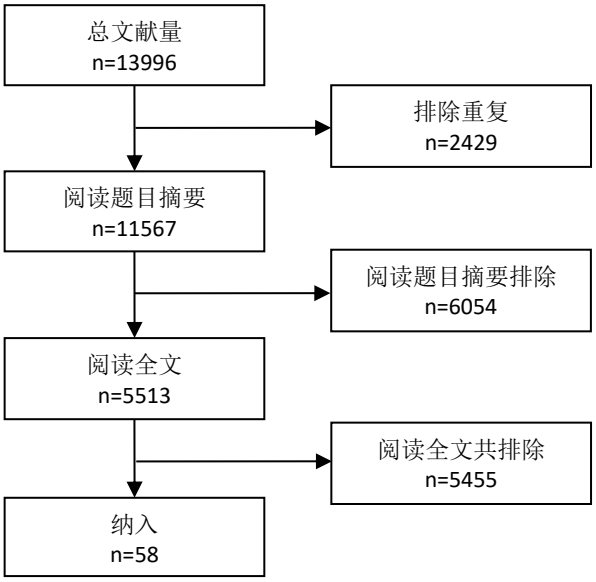

图 2 胃肠气滞证证据筛选流程图

③心脉气滞证

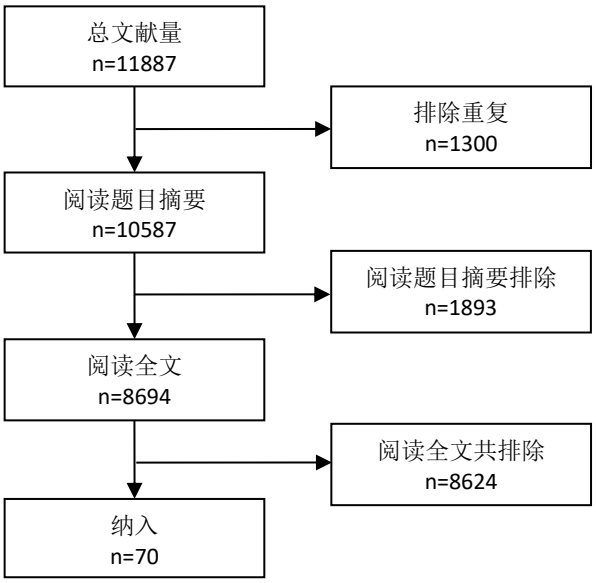

图 3 心脉气滞证证据筛选流程图

④肺气郁滞证

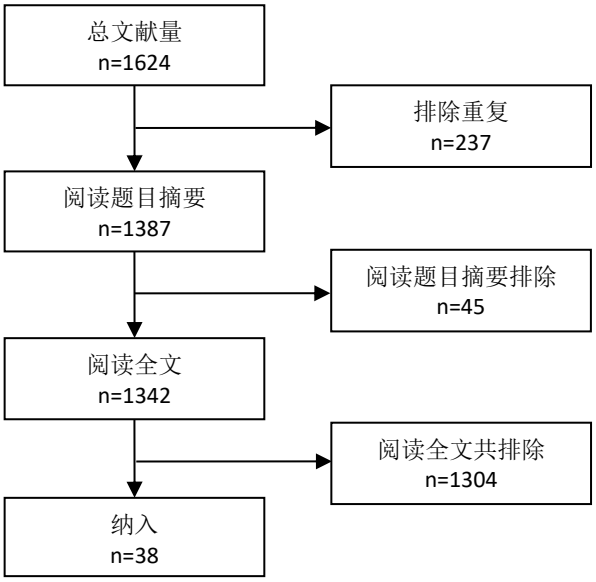

图 4 肺气郁滞证证据筛选流程图

3. 证据综合

3.1 肝郁气滞证辨证依据

症状归类	症状描述的频数				总频数
情志抑郁	情志抑郁	26	精神抑郁	23	93
	情绪不宁	11	情绪抑郁	3	
	抑郁	3	悲伤欲哭	2	
	情志失畅	2	疑病恐病	2	
	情绪低落	2	情志抑郁不乐	1	
	情绪不稳	1	心烦郁闷	1	
	抑郁烦闷	1	忧虑	1	
	郁郁寡欢	1	心绪不宁	1	
	心情不畅	1	产后心情抑郁，心神不安	1	
	闷闷不乐	1	精神不畅	1	
	多疑善虑	1	情志不舒	1	
	精神疲倦	1	情绪忧郁	1	
	抑郁多疑	1	抑郁善忧	1	
	精神悒郁	1	焦虑恐惧	1	
胸胁胀痛	胸胁胀痛	8	两胁胀痛	5	89
	胸胁胀满	5	胸胁或少腹胀满窜痛	5	
	胁肋胀痛或窜痛	4	脘胁胀痛,痛无定处	3	
	胁肋胀痛	3	胸胁胀痛，痛无定处	3	
	右胁胀痛	2	胁肋胀痛，痛无定处	2	
	胸胁作胀	2	两侧胁肋胀痛，走窜不定，甚则连及胸肩部	2	
	两胁胀满	2	胸胁胀满（或）窜痛	2	
	胸胁满闷	2	胸胁或少腹胀闷窜痛	2	
	胸胁窜痛	2	胸胁、少腹胀闷（满）疼痛，走窜不定	2	
	胸胁胀满不舒	2	胸胁胀闷窜痛	1	
	右胁或剑突下轻度疼痛，或间歇性隐痛，或绞痛，可牵扯至肩背部疼痛不适	1	胁肋胀痛，走窜不定	1	
	胸腹胀痛	1	胁肋胀痛，走窜不定，甚则引及胸背肩臂	1	
	胁腹作胀	1	向左季肋部、左背部窜痛	1	
	胸胁作痛	1	右胁疼为主，偶也有左、右胁疼多为胀痛或串痛，或连右背，或牵胸乳，或引少腹	1	
	胸胁苦满	1	胁胀，胁痛	1	
	胸胁痞满	1	胸胁、少腹胀满疼痛，走窜不定	1	
	胁肋胀满	1	少腹或胁肋胀痛	1	
	胸胀满疼痛	1	小腹胀满连及胸胁	1	
	胸胁脘腹胀满	1	胸胁、少腹胀痛	1	
	两肋胀窜疼痛	1	胸胁或少腹胀痛、窜痛	1	
	右胁闷胀窜痛	1	胁肋胀满或走窜作痛	1	
	胸胁不舒，痛无定处	1	胁腹胀满或作痛	1	
	胸胁（或兼背部）胀痛，痛无定处	1	胸闷胁胀或少腹胀痛	1	
	两侧胁肋胀痛，走窜不定	1	胁痛，或脘腹胀痛及两胁	1	
	胀痛，痛窜两胁	1	周身窜痛不适，时发时止	1	
腹部胀痛	腹胀	15	脘闷	12	69
	脘痞	5	少腹胀痛	4	
	食后胃脘胀满	4	脘腹胀痛	2	

	腹痛	2	行经少腹疼痛	2	
	少腹胀满窜痛	2	小腹胀痛	2	
	胸脘痞满	1	少腹胀闷窜痛	1	
	心下痞满	1	小腹有胀痛，痛无定处	1	
	胃脘胀痛	1	中上腹阵痛或窜痛	1	
	胃饱胀痛	1	少腹胀窜疼痛	1	
	脘腹窜痛	1	右上腹绞痛或钝痛	1	
	胸脘满闷	1	小腹作胀	1	
	脘满不舒	1	少腹胀痛拒按	1	
	脘腹痞胀	1	腹中胀满	1	
	脘痞胀	1	脘腹胀满	1	
	右上腹痛	1			
乳房胀痛	乳房胀痛	22	乳房结块	8	58
	妇女可见乳房作胀疼痛	6	乳房作胀	3	
	经前乳房、乳头胀痛	2	乳房胀硬而痛	2	
	乳房胀痛且情绪激动则痛剧	1	经前乳胀，腹痛	1	
	经前乳胀	1	经前乳胀	1	
	乳房胀窜疼痛	1	乳房胀，乳房痛	1	
	乳房窜痛	1	乳房胀硬、疼痛	1	
	乳房疼痛和（或）肿块，与月经、情绪变化相关	1	乳房胀痛，偶有刺痛	1	
	乳房肿块呈单一片状，质软，触痛明显	1	乳房肿块初起胀痛,引及两胸胁作胀	1	
	乳房内单发肿块,或结块如石,伴或不伴胀痛	1	乳房肿块，时觉胀痛	1	
太息	善太息	26	喜太息	11	58
	喜叹息	4	善叹息	3	
	抑郁太息	2	喜长叹息	2	
	叹息	1	善长太息	1	
	时作太息	1	喜叹气	1	
	时时太息	1	时欲太息	1	
	喜善太息	1	时发太息	1	
	时叹息	1	太息	1	
急躁易怒	急躁易怒	16	烦躁易怒	12	56
	心烦易怒	5	急躁	4	
	易怒	3	心烦	3	
	郁闷烦躁	2	急躁易怒，怒则加重	2	
	烦躁	1	情绪失调，家庭失和	1	
	易怒欲哭	1	情绪烦躁	1	
	心烦急躁易怒	1	性情急躁焦虑	1	
	易心烦	1	烦急善怒	1	
	易怒易躁	1			
嗳气	嗳气	29	嗳气频作	6	49
	嗳气呃逆	6	嗳气后觉舒	2	
	时有嗳气	1	吞酸嗳气	1	
	嗳气时舒缓	1	嗳气频作,得嗳气而胀痛稍舒。	1	
	嗳气频繁	1	时欲呃逆	1	
纳呆	不思饮食	11	纳呆	9	48

	食欲不振	7	纳差	5	
	食欲减退	4	食少纳差（纳差食少）	3	
	纳呆食少（食少纳呆）	2	饮食不振	1	
	纳食减少	1	纳少	1	
	不欲饮食	1	食少	1	
	饮食减少	1	纳食不香	1	
月经不调	月经不调	26	女子月事不调	2	42
	经色暗红或伴血块	2	女子月事不行	2	
	月经紊乱，先后不定期，量或多或少，	1	月经数月不行	1	
	月经周期延后，量少，色黯红或有小血块	1	月事错乱	1	
	月经不调，量或多或少，色紫红有血块，	1	月经可合并先后无定期或延后，经来不畅，色暗红	1	
	经行先后不定期，淋漓不顺畅	1	月经先后不定期	1	
	经色紫红，或挟有血块	1	经期先后不定，量或多或少，经行不畅，色紫有块	1	
胸闷	胸闷	21	胸闷不舒	8	38
	胸部满闷	6	胸胁胀闷	2	
	经前胸闷急躁	1			
大便不调	大便不调	10	便溏	4	31
	大便秘结	2	大便干结	2	
	便秘，欲便不畅，便下艰难	2	大便干结，欲便不得出	1	
	排便不畅	1	大便不爽	1	
	排便不爽，时溏时结	1	大便失常	1	
	便后不爽	1	腹泻	1	
	后重窘迫	1	大便艰难	1	
	大便不畅	1	后重窘迫	1	
咽喉异物感	咽部异物感（咽喉部异物感）	17	咽部如有物梗阻感	3	26
	咽有梗阻感	3	咽部梅核气	1	
	咽喉异物感，或如梅核，或如肿物，吞之不下，吐之不出，但不碍饮食	1	自觉咽中有物	1	
口苦	口苦	9	口苦咽干（咽干口苦）	7	24
	口干口苦（口苦口干）	6	口干	1	
	口苦而干	1			
失眠	失眠多梦	5	多梦	4	19
	失眠	4	少寐多梦	1	
	入睡困难	1	夜不入寐，或恶梦纷纭，惊恐易醒	1	
	易醒	1	夜寐不安	1	
	早醒	1			
症状随情绪波动加重	病情轻重与情志变化关系密切	7	疼痛、闷胀因情志变化而增减	4	18
	每于情志因素而发作	1	烦恼复发或加重	1	
	情志不遂时加重	1	与情志有关	1	
	情志不畅时加重	1	每因烦恼郁怒诱发	1	
	肿块、疼痛与月经周期、情志变化密切相关，经前或情绪不	1			

	佳时加重，经后减轻				
痛经	痛经	18			18
闭经	闭经	12			12
恶心	恶心	4	呕吐	4	11
	时有恶呕	1	恶心欲吐	1	
	喜呕	1			
胁下癥块	胁下癥块	4	胁下肿块	3	11
	右胁肋下痞块	1	乳癖、胁下积块	1	
	少腹结块	1	癥块	1	
嘈杂吞酸	泛酸	4	烧心	3	9
	嘈杂吞酸	2			
瘿瘤、瘰疬	瘿瘤、瘰疬	6	颈部瘿瘤	3	9
脉涩	脉涩	6			6
头痛	头痛	2	头昏头痛	1	6
	头痛剧烈	1	巅顶头痛	1	
	头目胀痛	1			
头晕	头晕目眩	4	头晕	1	5
肠鸣矢气	肠鸣矢气	3	肠鸣	1	5
	矢气则舒	1			
产后缺乳	产后乳汁分泌少，甚或全无；乳汁稠	2	产后乳汁涩少，浓稠，或乳汁不下	1	4
	两乳胀满作痛，乳汁不下，量少不畅，乳汁色黄质稠	1			
目赤痛	目赤	2	头目胀痛，眼压偏高	1	4
	时有视物昏朦，目珠微胀，轻度抱轮红赤，或瞳神稍大	1			
乏力	神疲乏力	2	倦怠乏力	1	4
	精神不振	1			
小便不通	小便不通或通而不爽，前列腺增大	1	小便淋漓不畅	1	4
	小便淋漓	1	排尿无力,余沥不尽	1	
肝大	肝区不适	2	肝大，胆囊肿大，脾大	1	3
阳痿	勃起无力，或勃起不坚，甚至不能勃起	1	阴茎逐渐萎软,或阳痿突生	1	3
	阳痿不举，或性交时不能射精，精子稀少、活力下降	1			
阴部疼痛	会阴部、或外生殖器区、或少腹、或耻骨区、或腰骶及肛周坠胀不适,似痛非痛,	1	会阴部、或外生殖器区、或下腹部、或耻骨上区、或腰骶及肛周坠胀不适， 以上部位似痛非痛	1	3
	阴部胀窜疼痛	1			
面色无华	面色无华	1	面色晦暗	1	2
耳鸣	耳鸣	2			2
性欲减退	性欲减退 ，乃至淡漠	1	性欲低下	1	2
不孕	婚后不孕	2			2
心悸	心悸	1	气怒怔忡	1	2
畏寒肢冷	畏寒肢冷	1			1
微热	微热	1			1
妇人脏躁	妇人脏躁	1			1

恶露	恶露量或多或少，色紫黯有块	1			1
斑色黄褐	斑色黄褐	1			1
面部烘热	面部烘热	1			1

3.1.1 肝郁气滞证症状名称归类的频数分析结果

表 2　肝郁气滞证症状归类的频数分析结果

表 3　肝郁气滞证舌象归类的频数分析结果

舌象归类	舌象描述的频数				总频数
苔薄白	苔薄白	49	苔薄	6	55
苔薄黄	苔薄黄	23	苔黄	4	30
	苔薄薇黄	1	苔燥黄	1	
	苔微黄	1			
舌质淡红	舌淡红	26	舌质淡	1	27
舌红	舌质红	14	舌边尖红	5	22
	舌质偏红	1	舌红有瘀点	1	
	舌质紫黯	1			
苔薄腻	苔薄腻	9			9
苔白	苔白	4	苔白厚	1	7
	苔白滑	1	苔白而薄	1	
舌质暗红	舌质暗红（舌暗红）	4	舌质暗	1	6
	舌质稍暗	1			

表 4　肝郁气滞证脉象归类的频数分析结果

脉象归类	脉象描述的频数				总频数
脉弦	脉弦	86	脉弦细（脉细弦）	9	120
	脉弦滑	8	脉弦数	7	
	脉细弦	2	脉弦缓	2	
	脉弦紧	2	脉沉细弦	1	
	脉沉弦	1	脉弦细数	1	
脉细	脉细	2			2

3.1.2 结论

肝郁气滞证候文献系统评价结论：

（1）证候名称归类及分析结果：肝郁气滞证、肝气郁结证、肝气郁滞证，以“肝郁气滞证”作为表述具有代表性。

（2）常见症状名称归类及分析结果：情志抑郁、急躁易怒、胀窜闷痛（胸胁、少腹、乳房等）、太息、症状随情绪波动加重、咽喉异物感、纳呆、失眠、大便不调、矢气、痛经、月经不调、舌红、无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）、脉弦、苔薄白、胸闷、苔薄黄、舌质淡红。

3.2 胃肠气滞证辨证依据

3.2.1 胃肠气滞证症状名称归类的频数分析结果

表 5　胃肠气滞证症状归类的频数分析结果

症状归类	症状描述的频数				总频数
嗳气或呃逆	嗳气	49	嗳气频作	35	104
	呃逆嗳气	8	嗳气频频	5	
	呃逆	3	噫气频作	2	
	嗳气频繁	2			
腹部胀满疼痛	腹痛腹胀	9	腹中胀痛	6	87
	腹部胀痛	5	少腹胀满窜痛	4	
	腹胀痛剧,肠鸣走窜不定	4	痛引少腹，时聚时散	4	
	腹痛兼胀闷不舒，攻窜不定，痛引少腹	4	脘腹痞胀疼痛	4	
	脘腹胀满	3	脘腹疼痛,胀满不舒，攻窜两胁	3	
	腹胀	3	少腹胀满	2	
	腹痛腹泻	2	脘腹胀痛	2	
	腹痛，脘腹闷胀	2	少腹作胀	2	
	腹部胀满疼痛,走窜不定	2	腹部痞胀、胀痛或窜痛	2	
	腹部胀满窜痛	1	胸腹痞满，甚则腹痛肠鸣	1	
	腹痛胀闷，痛引少腹	1	腹痛肠鸣泄泻	1	
	少腹作胀，甚则腹痛	1	胸腹满闷不适，但腹软	1	
	小腹胀满	1	腹中胀满	1	
	少腹绞痛，腹胀肠鸣	1	两胁肋部胀满不适	1	
	大腹胀痛,常连及胁肋,甚至胃脘、少腹,攻窜不定,拒按	1	脘腹胀痛,痛无定处，或痛引少腹，或痛窜两胁	1	
	痛时腹部或可扪及瘕块	1	脘腹胀满，叩之如鼓	1	
	少腹结滞，时急时缓，受寒则甚，得热则缓	1	腹部胀满或窜痛、腹胀	1	
	脘腹痞胀疼痛，走窜不定，痛而欲吐，或欲泻而不爽	1	腹痛而胀,走窜攻冲，痛引两胁或下连少腹	1	
	脘腹疼痛，胀满不舒，攻窜不定	1	腹部胀痛，攻窜不定	1	
	腹痛痛引少腹	1	腹满胀痛	1	
	腹部疼痛，胀满不舒，攻窜两胁	1	少腹胀痛，攻窜不定	1	
大便不调	便秘	10	大便干结，或不甚干结，欲便不得出，或便而不爽	7	81
	大便秘结	7	大便不畅	6	
	腹痛而欲吐或欲泻，泻而不爽	6	大便秘结，欲便但排出困难	3	
	大便干结	3	大便时干时溏	2	
	便秘、欲便不畅、便下艰难	2	大便不畅，欲解不得	2	
	排便困难，大便干结或不干	2	大便不调，时干时溏	1	
	大便或稀或结，或排便不爽或夹粘液	1	便秘,数日一行,大便干结,或涩滞不爽,欲便不得	1	

	欲便不畅，便下难	1	大便干结，欲便不得出，腹中胀满	1	
	腹痛则泻，泻后则舒，或腹泻与便秘交替	1	便后不爽	1	
	便次减少，便质干结，排便困难	1	大便干结，欲便不出，腹中胀满	1	
	便秘，欲便不畅，便下艰难	1	便后不畅	1	
	大便成形，排便不畅	1	大便不下	1	
	大便异常	1	欲便不得	1	
	大便稍干	1	泻后痛减	1	
	大便干	1	排便不畅	1	
	腹痛伴排便，大便干结难解	1	大便干结或不干，排便不畅，欲解不得	1	
	大便干结或排便次数减少，排便不畅	1	大便不畅，多不干结	1	
	腹痛作泻	1	便艰涩不行，粪便干结或不干而欲便不得	1	
	腹泻或便秘，时作时止	1	大便不通	1	
	便下艰涩	1	大便涩滞不行	1	
	腹痛伴便秘	1	大便秘结，欲便不得	1	
纳呆	纳食减少	8	纳呆	7	62
	食少	5	食少纳差	4	
	纳差	4	食后腹胀	3	
	食欲减退	3	食欲不振	3	
	食少纳呆	3	纳呆少馨	2	
	饮食减退	2	饮食减少	2	
	纳食不香	1	早饱纳差	1	
	食后饱胀	1	食欲下降	1	
	纳谷不香	1	不欲饮	1	
	食后腹胀或胀痛	1	纳减	1	
	不思饮食	1	噫气食少	1	
	得食痛加	1	纳谷欠佳	1	
	不欲饮食	1	纳少	1	
	饭后疼痛加剧	1	不能进食	1	
胁肋满闷	胸胁满闷	7	两胁疼痛	5	58
	两胁胀痛	5	胸胁胀满窜痛	5	
	胁腹痞满	4	胸胁痞满	3	
	两肋胀痛	3	两胁不舒	2	
	胁肋部疼痛	2	胁腹痞闷胀痛	2	
	胸胁胀满，走窜不定	2	两肋胀痛，食后尤甚	1	
	痛窜两胁	1	胁肋胀痛	1	
	脘痛连胁	1	胁肋胀满	1	
	胸胁作胀	1	胁痛	1	
	胁肋部胀满不适或疼痛	1	胁肋窜痛	1	
	两胁部胀痛	1	胸胁胀闷	1	
	胸胁不舒	1	素有胸胁痞闷胀满	1	
	胸部郁闷	1	胁腹胀痛，满闷不舒，痛无定处，或攻窜两胁，或痛引少腹	1	

	胸胁胀满	1	胸胁胀痛	1	
	两胁胀痛，攻窜不定	1			
矢气	矢气	43	矢气频作	4	57
	矢气后胀痛得减，或胀痛剧而无肠鸣矢气	3	得嗳气或太息则胀痛稍减	2	
	得嗳气、矢气后痛胀可缓解，或无肠鸣、矢气则胀痛加剧	2	排气	1	
	矢气不畅，得矢胀减	1	矢气后胀痛得减	1	
症状因情志波动而加重	情志不遂而加重	15	遇忧思恼怒加剧	7	56
	情绪急躁加剧	4	情志郁闷	3	
	每因情志不遂而痛增	2	每因情志不舒而加重	2	
	情志抑郁则加重	2	恼怒则疼痛加剧	2	
	情志不畅时加重	2	恼怒后病情加重	1	
	因情志不悦而发作	1	每遇工作紧张或劳累时上症加重	1	
	生气后病情加重	1	多因情志不畅或遭受强烈精神刺激引起	1	
	多在情志变化时诱发或病情加重	1	遇恼怒复发或加重	1	
	每因情志不畅或情绪紧张而发或加重	1	情志失衡	1	
	每于情绪异常时多发或加重	1	常因情志因素引起	1	
	病情与情绪密切相关	1	每因抑郁恼怒或情绪紧张诱发	1	
	症状随情绪波动反复	1	每因情志失调而发作或加剧	1	
	平时情绪抑郁不舒	1	大便困难情况随情绪波动而变化	1	
胃脘胀满疼痛	胃脘胀痛	9	胃脘疼痛	4	44
	胃脘胀满,攻撑作痛	4	胃脘胀满，饭后胀甚	3	
	胃脘胀满疼痛	2	胃脘胀闷、隐痛	2	
	胸脘痞闷	2	胃脘胀满疼痛,走窜不定	2	
	胃脘痞胀、胀痛或窜痛	2	上腹或胀或痛	1	
	胃脘胀痛、时轻时重	1	胃脘痞满隐痛	1	
	胃脘胀痛，饱闷不舒，痛无定处	1	胃脘胀痛或痞满	1	
	胃脘堵闷	1	胃脘胀闷疼痛	1	
	胃脘部胀满疼痛	1	脘闷	1	
	胃脘部胀痛或刺痛或胁痛，痛有定处，拒按，冷热不拘	1	胃脘痞满胀痛与日俱增	1	
	胃脘不舒	1	胃痛猝发	1	
	胃脘胀满或胀痛	1			
肠鸣	肠鸣	27			27
嗳腐吞酸	泛酸	3	嗳腐吞酸	3	24
	反酸	2	烧心反酸	2	
	嗳腐	2	吞酸嘈杂	2	
	吐酸	1	泛吐酸水	1	
	吞酸泛恶	1	恶心	1	

	烧心吐酸	1	泛酸嘈杂	1	
	嘈杂吐酸	1	吐酸苦水	1	
	烧心泛酸	1	反酸恶心	1	
急躁易怒	急躁易怒	6	烦躁易怒	4	23
	心烦易怒	3	喜怒	1	
	烦恼易怒	1	遇烦恼郁怒，则痛作或痛甚	1	
	平素易烦躁动怒	1	遇烦恼复发或加重	1	
	恼怒忧虑易发	1	烦躁易怒或郁郁寡欢	1	
	心烦	1	忿怒痛增	1	
	郁怒则发作或加重	1			
胸闷	胸闷	10	心烦胸满	1	15
	胸闷痞塞	1	胸膈胀满	1	
	胸脘满闷,痞塞不舒	1	胸膈痞满	1	
恶心呕吐	恶心呕吐	4	呕吐	4	10
	干呕	2			
太息	善太息	4	喜太息	3	10
	太息	1	喜叹息	1	
	喜长叹息	1			
口苦、咽干	口苦咽干	3	咽干口苦	2	9
	口苦	1	口干	1	
	口干咽燥	1	口干口苦	1	
失眠	失眠多梦	3	失眠	1	6
	眠差多梦	1	多梦	1	
精神抑郁	精神抑郁	2	心情抑郁	1	3
疝气胀痛	阴囊疝痛	1	疝气胀痛	1	2
口酸口臭	口酸，口粘	1	口臭	1	2
有明显伤食病史等	有明显伤食病史，或有感受外邪病史并伴有风寒、风热、暑湿等表证	2			2
后重窘迫	后重窘迫	2			2
月经不调	痛经，月经不调	1	痛经，月经不调	1	2
头昏	目眩	1	头昏	1	2
精神疲乏	精神疲乏	1			1
背部胀痛	背部胀痛	1			1
咽部如有物梗阻感	咽部如有物梗阻感	1			1
心悸	心悸	1			1
妇人可见经来乳胀	妇人可见经来乳胀	1			1

表 6　胃肠气滞证舌象归类的频数分析结果

舌象归类	舌象描述的频数				总频数
苔薄白	苔薄白	43	苔薄	3	50
	少苔	2	苔薄白微黄	1	

	舌苔白薄	1			
舌质淡红	舌质淡红	18	舌淡	9	27
苔腻	舌苔薄腻	16			16
苔薄黄	苔薄黄	10	舌苔黄腻	1	15
	苔黄	1	苔薄黄腻	1	
	苔黄厚腻	1	苔微黄	1	
舌红	舌质红	11	舌略红	1	14
	舌尖红	1	舌质红少津	1	
苔白	苔白	14			14
苔白厚	苔厚	6	苔白厚腻	2	9
	苔白厚	1			
舌质暗	舌质暗红	4	舌暗淡	2	7
	舌质暗	1			
舌苔白腻	舌苔白腻	1	苔薄白腻	1	2
舌胖淡	舌胖淡	1			1
苔薄质干	苔薄质干	1			1

表 7　胃肠气滞证脉象归类的频数分析结果

脉象归类	脉象描述的频数				总频数
脉弦	脉弦	83	脉弦细	9	115
	脉沉弦	8	脉弦滑	5	
	脉弦缓	4	脉弦紧	3	
	脉弦数	2	脉细弦	1	
脉沉	脉沉弦	8	脉沉细	1	11
	脉沉弱	1	脉沉	1	
脉细	脉弦细	9	脉沉细	1	11
	脉细弦	1			
脉滑	脉弦滑	5	脉滑	1	7
	滑脉数	1			
脉浮	脉浮	2	脉浮数	2	4
脉缓	脉弦缓	4			4
脉紧	脉弦紧	3			3
脉濡	脉濡	2			2
脉弱	脉沉弱	1			1
脉数	脉数	1			1
脉沉弦迟	脉沉弦迟	1			1

3.2.2 结论

胃肠气滞证候文献系统评价结论：

（1）证候名称归类及分析结果：胃肠气滞证、胃脘气滞证、气郁脘痛、肠道气滞证、小肠气滞证，以“胃肠气滞证”作为表述具有代表性。

（2）常见症状名称归类及分析结果：胃脘或腹部胀满疼痛、嗳气或呃逆、肠鸣、矢气、纳呆、嗳腐吞酸、大便不调、恶心呕吐、口苦、咽干、舌红、舌质暗、苔腻、苔白、无明显舌象变化（舌质淡红、苔薄白、苔薄黄）、脉弦、脉沉、

脉细、脉滑。

3.3 心脉气滞证辨证依据

3.3.1 心脉气滞证症状名称归类的频数分析结果

表 8　心脉气滞证症状归类的频数分析结果

症状归类	症状描述的频数				总频数
胸部憋闷	胸闷	29	心胸满闷	18	69
	胸闷痛	4	心胸胀满	2	
	胸闷如窒	2	胸闷心痛	2	
	胸部憋闷	1	胸骨后闷痛，有压榨感	1	
	胸闷不舒	1	心胸闷痛，痛无定处	1	
	胸部闷痛	1	心胸憋闷胀满	1	
	胸闷胸憋	1	心胸满闷不适	1	
	胸膺憋闷	1	平时胸闷不适,有压迫感	1	
	胸闷不舒，心前区不适	1	活动后胸闷加重	1	
太息	善太息	33	时欲太息	14	66
	太息	5	喜叹息	4	
	喜太息	3	善叹息	3	
	时欲叹息	1	叹气	1	
	喜叹气	1	食欲太息	1	
胸部胀痛	胸痛	9	隐痛阵发,痛无定处	5	54
	阵阵隐痛，痛无定处	4	心前区疼痛	3	
	隐痛阵发	3	走窜疼痛、夜间疼痛固定	3	
	胸痛时作，痛无定处	2	心胸胀痛	2	
	隐痛阵发,痛有定处	2	心痛	2	
	胸部胀痛	2	心胸疼痛	1	
	闷痛	1	胸中隐痛	1	
	心痛阵发，痛有定处	1	胸部隐痛阵作	1	
	心胸胀痛或窜痛	1	胸部胀痛，痛无定处	1	
	疼痛部位不固定	1	心胸疼痛时作	1	
	心胸憋闷疼痛，痛引肩背内臂，时作时止，或疼痛而胀	1	胸痛必伴疼痛,多为胀痛,亦有走窜、闪灼样疼痛者。	1	
	夜间休息时常感心前区及后背牵涉痛，两胁部胀痛、刺痛	1	胸痛，疼痛放射至肩背、前臂和胃脘部	1	
	胸口憋闷疼痛	1	疼痛阵发,痛有定处	1	
	胀痛阵发，痛无定处	1	疼痛阵发，痛无定处	1	
心情抑郁或心烦	心烦	9	情志抑郁	6	52
	精神抑郁	5	易怒	5	
	急躁易怒	4	烦躁	3	
	性情急躁	2	抑郁	2	
	心烦易怒	2	烦躁易怒	2	
	抑郁寡欢	1	精神不振	1	
	情志不舒	1	焦虑	1	

	闷闷不乐，情绪低沉	1	情绪郁闷易怒	1	
	焦虑、抑郁	1	急躁	1	
	精神抑郁，情绪不宁	1	易惊易怒	1	
	情志忧郁	1	焦虑不安	1	
症状随情绪波动加重	可因情志不遂而诱发或者加重	23	与情志相关	7	44
	情绪波动时容易诱发或加重	3	情志抑郁可诱发或加重	2	
	每因情志刺激诱发	2	遇事紧张，自觉压抑	1	
	常因不良情绪而诱发或加重，常随心情好转	1	活动后或情志不畅诱发或加重	1	
	情志不畅、烦躁	1	心烦，易紧张，多思多虑	1	
	抑郁，遇情志波动时容易诱发或加重	1	疼痛每因情志之变动而增减，常见情志抑郁、易怒	1	
胁肋胀满	胸胁胀满	6	胁胀	6	44
	胁肋胀痛	3	胸胁胀痛	2	
	两胁胀痛	2	胸胁胀闷	2	
	胸胁苦满，胁肋胀痛	1	胸胁疼痛	1	
	两胁胀满	1	胸胁胀痛，痛无定处	1	
	痛及胁肋	1	胸胁胀闷窜痛	1	
	胸胁胀痛，痛引肩背	1	胸胁满闷或隐痛	1	
	胁肋部胀痛	1	胸胁胀闷，走窜疼痛	1	
	胁肋胀满不适	1	胁肋胀痛不舒	1	
	两胁区胀	1	胸胁闷痛	1	
	胸胁作胀	1	胸胁胀痛或攻痛	1	
	胸胁胀痛、窜痛	1	两胁窜引	1	
	胁痛	1	胸胁痛时作，痛无定处	1	
	两胁胀痛	1	胸胁胀闷，甚或疼痛	1	
	胸胁苦满	1			
脘腹胀闷	脘腹胀闷	8	腹胀	7	43
	脘腹胀满	4	脘胀	4	
	胃脘痞闷	3	胃脘胀闷	3	
	脘痞胀满	2	少腹胀痛、窜痛	2	
	脘腹胀痛	1	少腹胀闷，走窜疼痛	1	
	胃痛	1	胃脘不适	1	
	脘闷	1	脘腹胀	1	
	少腹胀闷窜痛	1	脘腹痞满	1	
	时感胃脘部嘈杂感，进食后更甚	1	胃脘胀闷不适	1	
嗳气	嗳气	17	得嗳气则舒	12	32
	嗳气频作	2	嗳气打嗝	1	
心悸	心悸	18	心慌	3	30
	心悸怔忡	2	心悸阵作	1	
	自觉惊慌不安、心中急剧跳动，无法自主	1	心悸时作，月经前后心悸加重	1	
	自觉心中跳动不安	1	心悸频发	1	
	心悸心慌	1	月经前后心悸加重	1	

失眠	失眠	11	寐差	3	25
	夜寐差	2	夜寐不安	2	
	夜间睡眠差	1	少寐	1	
	夜寐 6~7 小时,睡眠浅	1	睡眠欠佳	1	
	睡眠差	1	睡眠较差	1	
	失眠，入睡困难	1			
矢气	得矢气则舒	10	矢气	8	18
头晕	头晕	13	头昏	1	17
	眩晕	1	头闷	1	
	晕眩	1			
气短	气短	15	气息短促	1	16
乏力	乏力	10	神疲乏力	2	15
	全身乏力	1	全身疲乏,双下肢乏力	1	
	疲乏	1			
纳呆	不思饮食	5	纳差	4	15
	纳呆	4	饮食欠佳	1	
	纳谷不馨	1			
大便不调	大便干	4	大便不调	2	10
	大便时干时溏	1	便秘	1	
	大便不成形	1	大便失常	1	
头痛	头痛	3	头胀	2	9
	巅顶头痛	1	头胀痛不适	1	
	头痛发胀	1	头胀目痛	1	
月经不调	月经不调	7	女子月事不行	1	8
口苦	口苦	4	口干	1	7
	口干口苦	1	口干苦	1	
多梦	多梦	6			6
憋气	憋气	5	活动后憋气加重	1	6
汗出	汗出	2	自汗	2	5
	心慌出汗	1			
乳房胀痛	妇女乳房胀痛	3	经前乳房结块胀痛	1	5
	妇女可见乳房作胀疼痛	1			
痛经	痛经	2	经行腹痛	1	3
咽有梗阻感	咽有梗阻感	1	咽干痛，咽部有异物感	1	3
	咽喉可有异物感	1			
局部或全身胀满、疼闷、胀痛	局部或全身胀满、疼闷、胀痛	1	局部胀满不适	1	2
善惊易恐	易惊	1	胆小易惊	1	2
颈项不适	颈项不适	1	颈肩板滞	1	2
耳鸣	耳鸣	2			2
神倦懒言	神倦懒言	1	懒言	1	2
闭经	闭经	2			2
呕吐	呕吐	1	时作呕吐	1	2
停经	停经	1			1
坐卧不安	坐卧不安	1			1
气上冲感	气上冲感	1			1
四肢凉	四肢凉	1			1

烘热	烘热	1			1
脱发	脱发	1			1
面色少华	面色少华	1			1
口中乏味	口中乏味	1			1
瘿瘤、瘰疬	聚于颈部两侧或胁下多有肿块	1			1
面色萎黄	面色萎黄	1			1
腰酸	腰酸	1			1
手抖	手抖	1			1

表 9　心脉气滞证舌象归类的频数分析结果

舌象归类	舌象描述的频数				总频数
苔薄白	苔薄白	29	苔薄	25	54
舌质淡红	舌质淡红（舌淡红）	15	舌质红（舌红）	12	35
	舌淡（舌质淡）	6	舌边尖略红	1	
	舌边尖红	1			
苔腻	苔薄腻	22	苔腻	2	25
	苔白腻	1			
舌质暗	舌暗	6	舌质暗	4	18
	舌质紫暗	2	舌黯红	2	
	舌质偏暗	1	唇舌紫黯	1	
	舌质微黯	1	舌淡暗	1	
苔薄黄	苔薄黄	9			9
苔白	苔白	5			5
苔黄腻	苔黄	1	苔微黄腻	1	3
	苔黄腻	1			
舌面有裂纹	舌面有裂纹	1			1

表 10　心脉气滞证脉象归类的频数分析结果

脉象归类	脉象描述的频数				总频数
脉弦	脉弦	41	脉弦细（脉细弦）	23	79
	脉弦涩	3	脉弦结代	2	
	脉弦而有力	2	脉弦滑	2	
	脉弦略数	1	脉弦细涩	1	
	脉象多弦	1	脉弦数	1	
	弦脉	1	脉细微弦	1	
脉沉	脉沉弦	4	脉沉	2	7
	脉沉涩	1			
脉细	脉细数	1	脉细结代	1	4
	脉细涩	1	脉细	1	
脉涩	脉涩	4			4
脉结代	脉结	2	脉结代	1	3
脉数	脉数	1	脉略数	1	2
脉代	脉代	2			2
脉促	脉促	1			1
脉疾	脉疾	1			1

3.3.2 结论

心脉气滞证候文献系统评价结论

（1）证候名称归类及分析结果：心脉气滞证、气滞心脉证、气滞心胸证，以“心脉气滞证”作为表述具有代表性。

（2）常见症状名称归类及分析结果：胸部憋闷或胀痛、气短、心情抑郁或心烦、失眠、症状随情绪波动加重、心悸、头晕、头痛、乏力、矢气、舌质暗、苔腻、无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）、脉弦、脉细。

3.4 肺气郁滞证辨证依据

3.4.1 肺气郁滞证症状名称归类的频数分析结果

表 11　肺气郁滞证症状归类的频数分析结果

症状归类	症状描述的频数				总频数
咳嗽	咳嗽	18	呛咳	4	35
	干咳	2	咳嗽喘促	1	
	渐至喉痒呛咳,每于夜半子丑咳嗽加剧	1	咳甚则引及胸背肩臂，患侧尤甚	1	
	咳声短促	1	咳嗽剧烈	1	
	咳嗽咳痰	1	阵发性呛咳	1	
	咳嗽前多有咽痒、喉中发痒先兆,然后连续咳嗽,呈阵发性、痉挛性,咳声响亮	1	咳嗽频频,咽喉发痒,痒必咳嗽,迁延日久不愈,可呈阵发性、痉挛性咳嗽	1	
	上气咳逆阵作	1	咳嗽频繁,日夜不宁	1	
胸胁胀痛	胸胁胀痛	5	两胁胀痛	3	34
	胸胁胀满	3	胁肋胀满	2	
	胸胁胀闷	2	胁肋胸腹胀痛	1	
	胁胸胀痛	1	咳引胁痛胀满	1	
	咳痛引胁下	1	胸胁胀痛，胸前闷胀	1	
	胸胁胀闷窜痛	1	两胁不舒	1	
	劳伤后突然胸肋痛	1	胁下肿块	1	
	胸胁胀满疼痛，走窜不定	1	咳引两肋胀痛	1	
	胸胁胀满窜痛	1	胁满	1	
	胁痛	1	咳则胁肋部胀满或刺痛	1	
	胸胁部胀痛	1	两胁胀满	1	
	胸胁胀闷或窜痛	1	两胁时痛	1	
咯痰、少痰	少痰	4	喉中痰鸣不甚，或无痰声	3	25
	喉中痰鸣不著	2	痰粘如絮不易咯出	2	
	无痰或少量白痰	2	咯白痰	1	
	痰少并且十分粘稠	1	无痰或咳痰不多	1	
	干咳无痰或有痰	1	干咳少痰	1	
	有痰或无痰	1	咳痰黄稠甚或咳血	1	
	咳痰	1	喉中痰鸣。无痰或白黏	1	

			稠痰		
	痰少质黏	1	痰量少,痰质黏稠	1	
	痰少	1			
症状随情绪波动加重	常因情志刺激而诱发。平素多忧思抑郁	3	忧思抑郁.每遇情志刺激而诱发	2	22
	心情抑郁，每因抑郁或情绪紧张而发泄泻	1	病情随着情绪的变化而发生变化	1	
	平素情志不畅	1	每因情志不畅而加重	1	
	常遇情绪波动而增加	1	每因情志因素而发作	1	
	多伴情绪焦虑紧张	1	常因情志因素诱发，情志抑郁	1	
	抑郁太息;与情志不遂有关	1	情志不遂、心情抑郁	1	
	每于情绪不佳时加剧	1	每与情志因素有关	1	
	病情每因情绪变化而波动	1	常因大怒或劳伤后起病.平素情志抑郁	1	
	每遇情志刺激而诱发	1	病情轻重与情绪变化的关系密切	1	
	因情志不畅紧张劳累或由吸入性致敏原而发	1			
胸闷	胸闷	14	胸部憋闷	1	19
	胸部胀闷	1	胸闷不舒	1	
	胸部闷塞	1	胸闷不得平卧	1	
情志抑郁或急躁易怒	情志抑郁	3	精神抑郁,情绪不宁	2	18
	情志不调，或抑郁太息	1	情志抑郁或急躁易怒	1	
	情绪紧张，焦虑不安。情志抑郁或易怒	1	神情抑郁、情感脆弱，烦闷不乐、忧虑脆弱	1	
	平素情绪易怒	1	郁怒	1	
	精神抑郁	1	情志抑郁或烦躁	1	
	平素常多忧思抑郁	1	躁烦不安	1	
	心烦	1	情绪抑郁不舒	1	
	心烦易怒	1			
太息	善太息	9	喜叹息	3	15
	太息	2	时欲太息	1	
咽有梗阻感	咽中如窒	6	咽喉部有异物感	2	14
	咽部隐痛	1	咽中不适	1	
	咽中介介如梗状	1	咽中似有梗物	1	
	咽有梗阻感	1	咽中如有异物，吞之不下，咯之不出，	1	
喘息上气	喘鸣气逆	2	咳喘不已	2	11
	喘息上气	1	喘促气急,喉间哮鸣有声	1	
	上气喘急	1	喘息	1	
	喘咳哮鸣	1	喘息发作或加重	1	
	喘后如常人	1			
咽干	口苦咽干	4	口苦	2	11
	咽干	2	口干苦	1	
	口干、甚则咽干口苦	1	口干	1	
失眠	失眠	7	夜寐不安	1	11

	睡眠质量差	1	夜寐欠安，难以入睡	1	
	少寐	1			
腹部胀痛	少腹胀闷窜痛	2	腹胀	2	10
	少腹胀痛	1	脘腹胀满	1	
	小腹胀痛	1	少腹胀闷	1	
	腹痛	1	少腹胀满窜痛	1	
气短	发时突然呼吸短促，息促气憋	6	气短	3	9
纳呆	纳呆	2	纳呆不欲饮食	1	8
	食少	1	纳差	1	
	纳少	1	纳减	1	
	食欲不振	1			
心悸	心悸	6	心慌	1	7
月经不调	月经不调	3	月经不调，痛经	1	6
	女子多与月经周期密切相关	1	与月经周期有关	1	
乳房胀满	乳房胀痛	4	乳房肿块胀痛	1	5
胸痛	胸痛	4			4
胃脘胀闷	胃脘胀闷	1	脘闷	1	3
	脘痞	1			
头晕	头晕目弦	1	头昏	1	3
	头晕	1			
面红目赤	面红目赤	2	面红	1	3
气胀	气胀	1	气胀及背	1	2
嗳气	嗳气	2			2
头痛	头痛	2			2
大便失常	大便失常	1	大便溏	1	2
气促	气促	1	呼吸急促	1	2
坐卧不安	不能平卧	1			1
打鼾	眠时打鼾，时断时续，时时憋醒	1			1
瘿瘤	颈部瘿瘤	1			1
乏力	乏力	1			1
口渴欲饮	口渴欲饮	1			1
声嘶	声嘶	1			1
多由闻到刺激性气味引起	多由闻到刺激性气味引起	1			1

表 12　肺气郁滞证舌象归类的频数分析结果

舌象归类	舌象描述的频数				总频数
苔薄白	苔薄白	16	苔薄	6	25
	舌苔薄白	3			
舌红	舌红	4	舌质红	4	11
	舌略红	1	舌边红	1	
	舌呈红色或者是舌边呈红色	1			
舌淡红	舌淡红	7	舌质淡红	1	9

	舌质淡	1			
苔薄黄	舌苔薄黄	4	舌苔较薄呈现黄色	1	6
	苔黄	1			
苔薄腻	舌苔薄腻	2	舌苔厚腻，常苔上水滑	1	4
	苔薄白腻	1			
苔白	苔白	3			3
舌质淡白	舌淡白	1	舌质淡白	1	2
舌淡胖	舌体胖质暗	1	舌淡胖	1	2
舌质暗	舌暗淡	1			1

表 13　肺气郁滞证脉象归类的频数分析结果

脉象归类	脉象描述的频数				总频数
脉弦	脉弦	34	脉弦细	5	43
	脉弦数	3	脉弦而数	1	
脉细	脉弦细	5			5
脉数	脉弦数	3	脉弦而数	1	4
脉沉	脉沉弱	1	脉沉弱	1	1
脉弱	脉沉弱	1	脉沉弱	1	1

3.4.2 结论

肺气郁滞证候文献系统评价结论

（1）证候名称归类及分析结果：肺气郁滞证、气郁伤肺证、气郁肺证、肺气郁痹证，以“肺气郁滞证”作为表述具有代表性。

（2）常见症状名称归类及分析结果：胸闷、咳嗽、喘息上气、气短、症状随情绪波动加重、情志抑郁或急躁易怒、咯痰、少痰、咽干、咽有梗阻感、失眠、纳呆、舌红、苔白、无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）、脉弦、脉细、脉浮。

（六）临床调研

1.调研方案确定的过程及方法

根据文献系统评价结果，选择全国各地专家进行德尔菲专家问卷，见附件 2。条件：1）为提高问卷的可行性、权威性，选择大于等于 80%具备副高级及以上职称的专家，并从事 10 年以上的中医及中西医结合专业的临床或科研工作；2）为提高问卷的理解度与可行性，选择小于等于 20%青年临床医生；3）为提高问卷的普遍性与统一性，选择全国有代表性的区域。数量：为满足 Delphi 法的条件，专家人数为 15～50 位。

2.调研对象分布情况

此次研究均进行了 3 轮问卷调查，选择的专家均是长期在临床或科研工作中

从事中医及中西医结合治疗精神科、妇科、乳腺科等医学行业的专家。共有 38 名专家，其中男性 23 名，女性 15 名；年龄≤40 岁 5 名，41-50 岁 13 名，51-60 岁 18 人，>60 岁 2 人；博士 28 名，硕士 9 名，本科 1 名；博士生导师 22 名（58%），硕士研究生导师 12 名（32%），医师和研究员各 2 名（5%）；专家以工作年限大于 20 年的为主，有 27 名（71%），16-20 年的 4 名（11%），11-15 年的 3 名（8%），6-10 年的 4 名（11%）。地区：这些专家分别来自湖南、广东、上海、北京、天津、湖北、安徽、广西、江西、河南 10 个城市。

3.调研结论

3.1 根据专家线下问卷意见，条目修改总结如下：

（1）气滞证

①“舌象无明显变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）“改为”舌质淡红或舌质暗，苔薄白或薄黄“；

②“太息”放次证；

③“症状随情绪波动加重”改为“遇情志不遂时易诱发或加重”；

④“头晕”改为“头痛或头晕”；

⑤补充“窜痛”；

⑥胀闷疼痛（胸胁、脘腹、乳房、少腹等），胀重于痛。

（2）肝郁气滞证

①“舌象无明显变化”改为“舌质淡红或舌质暗，苔薄白或薄黄”；

②“症状随情绪波动加重”改为“遇情志不遂时易诱发或加重”；

③“脉弦”改为“脉弦或弦滑”；

④补充“痞满”、“乳房结节”；

（3）胃肠气滞证

①“胃脘或腹部胀满疼痛”改为“胃脘或腹部胀满疼痛，走窜不定，矢气、嗳气后痛减”；

②补充“舌淡红”；

③补充“腹部时聚包块”；

④补充“痛而欲吐或欲泻”。

（4）心脉气滞证

①“胸部憋闷或胀痛”应明确部位；

②“症状随情绪波动加重”改为“遇情志不遂时易诱发或加重”；

③补充“时欲太息”。

（5）肺气郁滞证

①“舌红”改为“淡暗或红”；

②“胸闷”改为“胸闷或胸痛”；

③“症状随情绪波动加重”改为“遇情志不遂时易诱发或加重”；

④补充“胸痛”、“舌暗红”。

3.2 德尔菲法专家咨询问卷信度和效度评价

对德尔菲法专家咨询问卷的信度评价，采用 Cronbach α 系数分析，评价问卷的可靠性和有效性。分析结果见下表 40，可以看出，亚型证的信度均大于 0.6，提示该问卷可靠性和有效性良好。气滞证的信度大于 0.4，提示较好的可靠性。

表 14 德尔菲法专家咨询问卷信度评价（%）

项目	信度 (Cronbach α系数)
气滞证	0.450
肝郁气滞证	0.607
胃肠气滞证	0.753
心脉气滞证	0.717
肺气郁滞证	0.831

3.3 条目筛选

表 15 气滞证的条目筛选

气滞证	均数	满分频率%	等级和%	变异系数%	删除
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛	3.95	94.59%	98.65%	5.73%	
2.情志抑郁	3.00	59.46%	75.00%	50.22%	
3.急躁易怒	2.68	37.84%	66.89%	51.45%	
4.太息	2.95	40.54%	73.65%	39.42%	
5.舌质淡红	2.41	21.62%	60.14%	52.46%	
6.苔薄白	2.57	27.03%	64.19%	48.38%	
7.脉弦	3.70	72.97%	92.57%	13.85%	
8.脉沉弦	2.41	24.32%	60.14%	56.74%	

表 16 肝郁气滞证的条目筛选

肝郁气滞证	均数	满分频率%	等级和%	变异系数%	删除
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸胁、少腹、乳房等）	4.00	100.00%	100.00%	0.00%	

2.情志抑郁	3.97	97.30%	99.32%	4.08%	
3.急躁易怒	3.41	64.86%	85.14%	30.12%	
4.太息	3.49	64.86%	87.16%	24.61%	
5.咽喉异物感	2.95	21.62%	73.65%	24.89%	
6.痛经	2.70	18.92%	67.57%	34.26%	
7.月经不调	2.76	16.22%	68.92%	32.01%	
8.舌质淡红	2.54	32.43%	63.51%	54.60%	
9.舌质暗	1.97	10.81%	49.32%	68.19%	×
10.苔薄白	2.73	29.73%	68.24%	44.78%	
11.脉弦	3.62	72.97%	90.54%	21.63%	
12.脉沉弦	2.68	40.54%	66.89%	53.60%	

表 17　胃肠气滞证的条目筛选

胃肠气滞证	均数	满分频率%	等级和%	变异系数%	删除
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘部、腹部等）	3.89	89.19%	97.30%	7.98%	
2.肠鸣	3.35	54.05%	83.78%	27.06%	
3.矢气	3.38	56.76%	84.46%	26.07%	
4.嗳气	3.68	72.97%	91.89%	15.56%	
5.呃逆	3.27	51.35%	81.76%	30.70%	
6.纳呆	3.03	37.84%	75.68%	36.42%	
7.情志抑郁	3.11	48.65%	77.70%	37.24%	
8.急躁易怒	2.43	24.32%	60.81%	57.78%	
9.太息	2.62	18.92%	65.54%	43.76%	
10.呕吐	2.73	27.03%	68.24%	42.29%	
11.嗳腐吞酸	2.73	18.92%	68.24%	38.70%	
12.腹部时聚包块	3.03	32.43%	75.68%	30.23%	
13.舌质淡红	2.54	27.03%	63.51%	53.04%	
14.苔薄白	2.54	24.32%	63.51%	49.78%	
15.苔腻	2.49	13.51%	62.16%	46.40%	
16.脉弦	3.38	56.76%	84.46%	26.07%	
17.脉沉弦	2.68	27.03%	66.89%	46.84%	
18.脉弦滑	2.68	29.73%	66.89%	46.02%	

表 18　心脉气滞证的条目筛选

心脉气滞证	均数	满分频率%	等级和%	变异系数%	删除
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）	3.89	89.19%	97.30%	7.98%	
2.气短	3.19	51.35%	79.73%	35.59%	
3.心悸	3.54	59.46%	88.51%	16.86%	
4.情志抑郁	3.22	56.76%	80.41%	36.96%	
5.急躁易怒	2.62	32.43%	65.54%	53.47%	
6.太息	2.78	24.32%	69.59%	37.48%	
7.失眠	2.84	29.73%	70.95%	40.56%	
8.舌质淡红	2.14	24.32%	53.38%	71.54%	
9.舌质暗	3.22	40.54%	80.41%	26.20%	

10.苔薄白	2.70	27.03%	67.57%	42.90%
11.脉弦	3.49	64.86%	87.16%	24.61%
12.脉弦细	2.68	37.84%	66.89%	52.17%
13.脉沉弦	2.86	37.84%	71.62%	43.07%

表 19　肺气郁滞证的条目筛选

肺气郁滞证	均数	满分频率%	等级和%	变异系数%	删除
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸部等）	3.84	83.78%	95.95%	9.60%	
2.气喘	3.84	86.49%	95.95%	11.36%	
3.咳嗽	3.32	56.76%	83.11%	30.53%	
4.气短	3.59	62.16%	89.86%	15.11%	
5.情志抑郁	2.76	37.84%	68.92%	48.01%	
6.急躁易怒	2.16	24.32%	54.05%	69.28%	
7.太息	2.62	29.73%	65.54%	50.44%	
8.咯痰	3.00	37.84%	75.00%	37.97%	
9.少痰	2.68	29.73%	66.89%	48.42%	
10.舌质淡红	2.30	32.43%	57.43%	69.28%	
11.舌质暗	2.86	24.32%	71.62%	36.44%	
12.苔薄白	2.62	32.43%	65.54%	51.22%	
13.苔薄腻	2.24	13.51%	56.08%	57.15%	
14.脉弦	3.38	48.65%	84.46%	19.89%	
15.脉沉弦	2.97	27.03%	74.32%	31.75%	
16.脉弦细	2.89	27.03%	72.30%	37.52%	

注：专家对各指标的意见的集中程度由算术均数、满分频率、等级和反映，算术均数、满分频率越大，等级和越小，则提示该条目的地位越重要，专家的意见越集中，其协调程度有变异系数反应，主要用来判断各专家对每个条目的评价是否存在较大分歧，或者找出专家高度协调的条目。选择符合的条件：均数>2，满分比＞30%，等级和>满分的 30%，变异系数（CV）≤30%予以保留。

结合表 15-19 的结果表明：专家意见的集中程度与协调程度较好，经过统计学筛选，条目均可保留，可进行条目赋权。

3.4 气滞证专家群决策层次分析结果

分析最后一轮的专家咨询结果，共咨询了 37 位专家。每位专家都对气滞证辨证诊断的各个层次进行了两两比较，专家群决策决策结果如下：

3.4.1 气滞证专家群决策层次模型树和权重分析结果

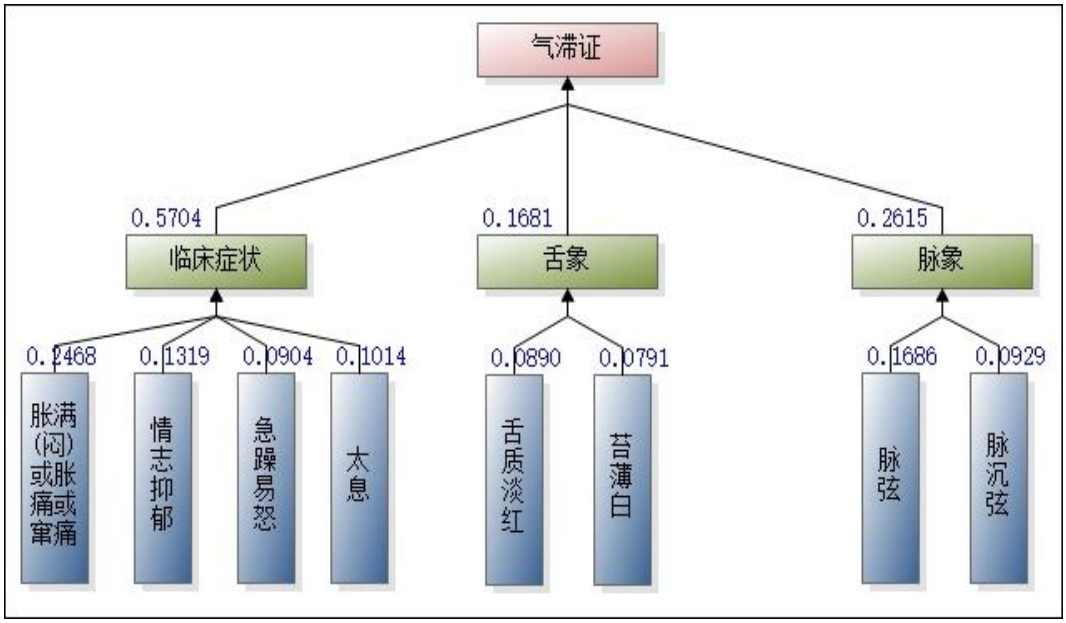

图 5　气滞证专家群层次分析结果

从图 5 中可以看出层次分析方案层（即中医四诊）和中间层（临床症状、舌象与脉象）均进行了赋权，专家群决策层次模型树的权重可作为气滞证量化诊断的依据。

3.4.2 气滞证专家群对中间层临床症状、舌象和脉象权重决策结果

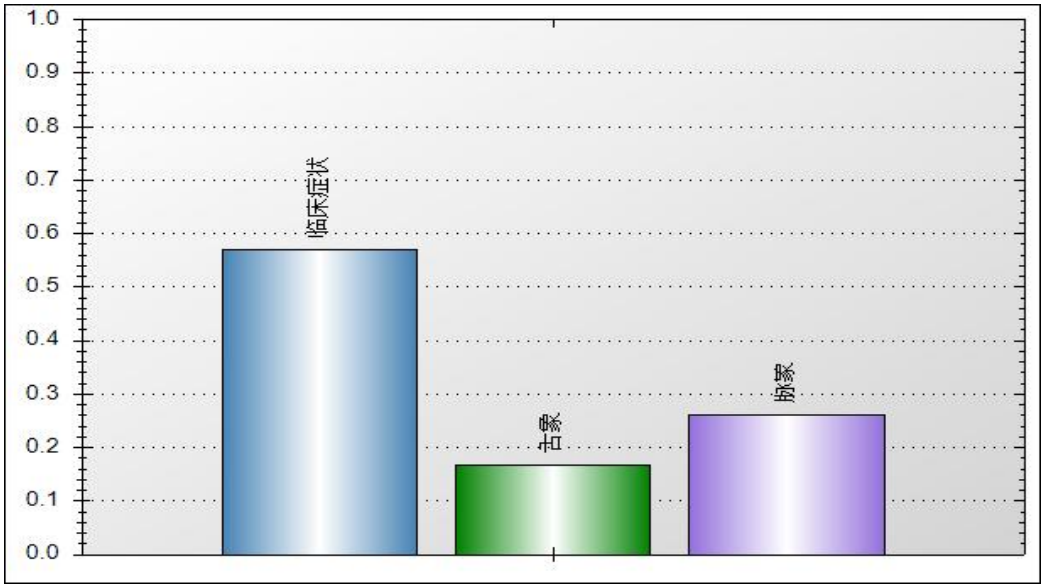

图 6　气滞证第 I 层专家群权重决策结果

从图 6 中可以看出中间层专家群决策临床症状权重比舌象和脉象大，提示临床症状在辨证时可能更重要一些。

3.4.3 气滞证四诊专家群决策权重分析比较结果

表 20　气滞证第Ⅱ层各指标专家群权重决策比较

备选方案	权重
胀满(闷)或胀痛或窜痛	0.2468
脉弦	0.1686
情志抑郁	0.1319
太息	0.1014
脉沉弦	0.0929
急躁易怒	0.0904
舌质淡红	0.089
苔薄白	0.0791

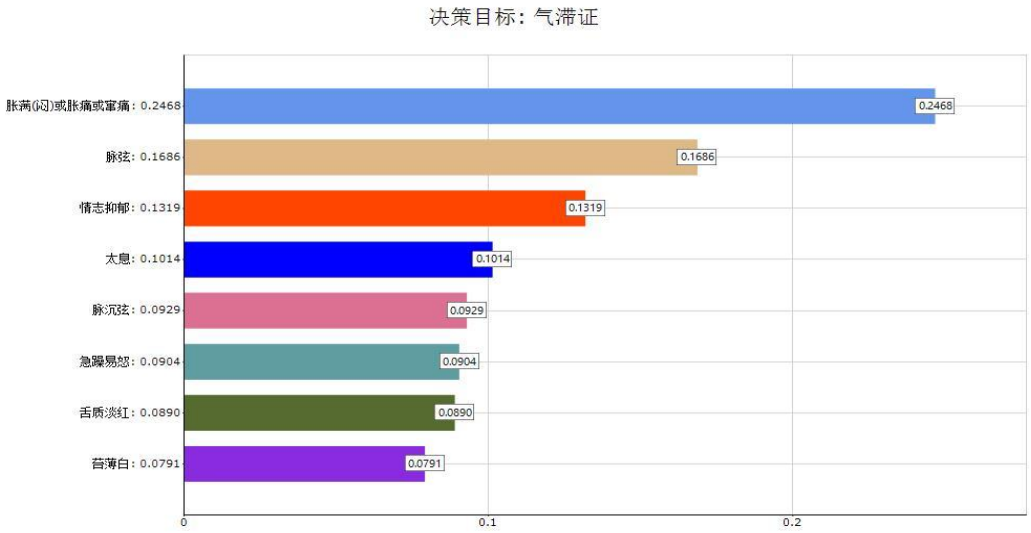

图 7　气滞证第Ⅱ层专家群权重决策结果

气滞证第一轮专家群决策结果表明：层次分析法两两比较后，专家群决策权重大于 0.1 的四诊指标分别为：胀满(闷)或胀痛或窜痛、脉弦、情志抑郁、太息；除了苔薄白，其余四诊指标的权重均大于 0.08。

3.5 肝郁气滞证专家群决策层次分析结果

分析最后一轮的专家咨询结果，共咨询了 37 位专家。每位专家都对肝郁气滞证诊断的各个层次进行了两两比较，专家群决策决策结果如下：

3.5.1 肝郁气滞证专家群决策层次模型树和权重分析结果

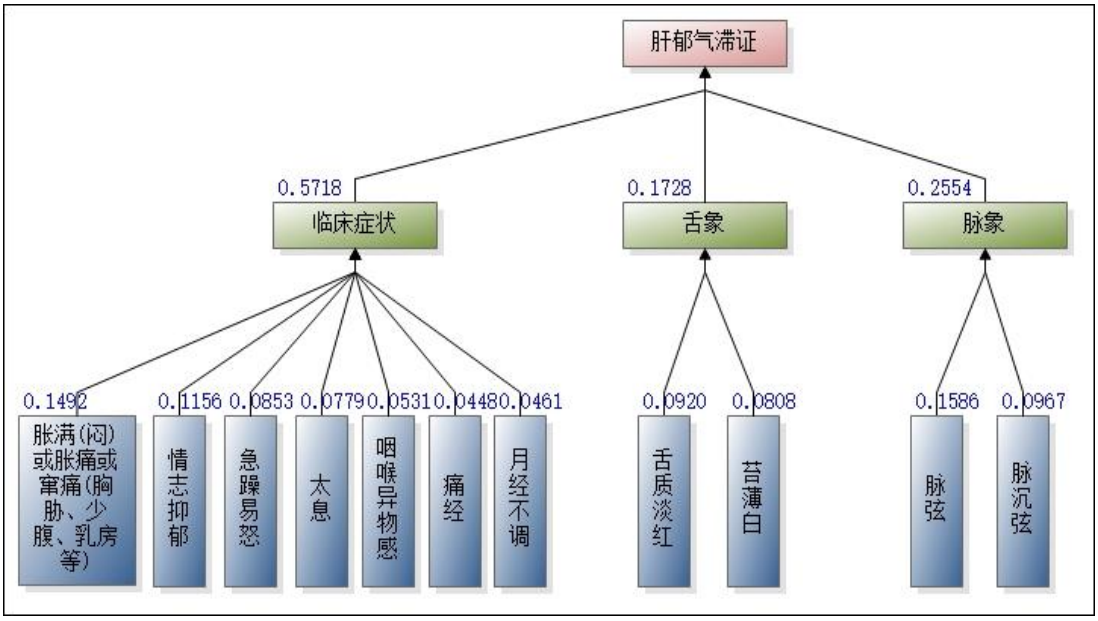

图 8　肝郁气滞证专家群层次分析结果

从图 8 中可以看出层次分析方案层（即中医四诊）和中间层（临床症状、舌象与脉象）均进行了赋权，专家群决策层次模型树的权重可作为肝郁气滞证量化诊断的依据。

3.5.2 肝郁气滞证专家群对中间层临床症状舌象和脉象权重决策结果

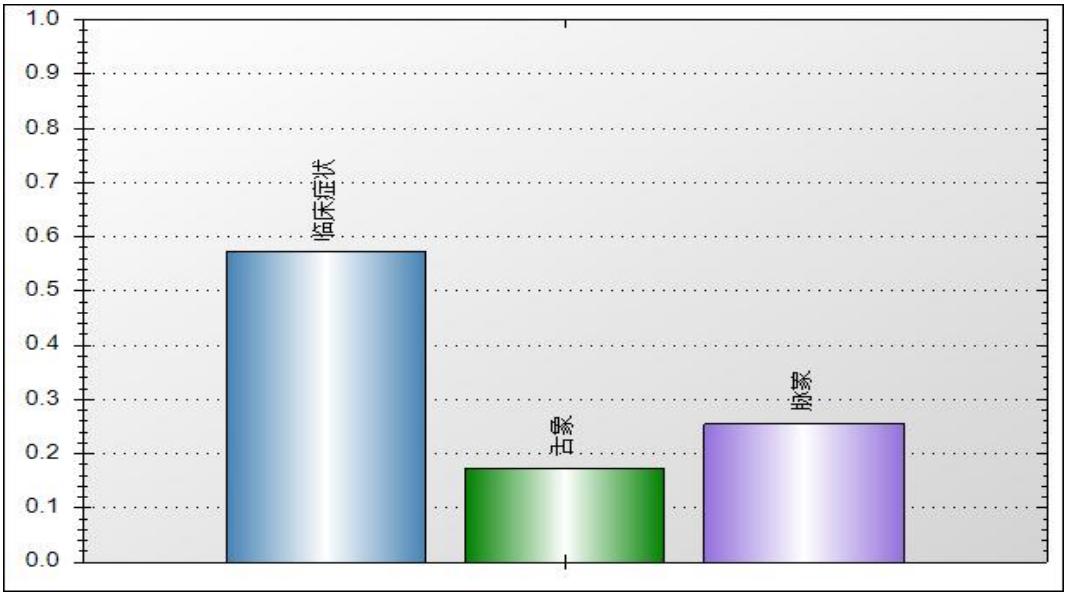

图 9　肝郁气滞证第 I 层专家群权重决策结果

从图 9 中可以看出中间层专家群决策临床症状权重比舌象和脉象大，提示临床症状在辨证时可能更重要一些。

3.5.3 肝郁气滞证四诊专家群决策权重分析比较结果

表 21　肝郁气滞证第Ⅱ层各指标专家群权重决策比较结果

备选方案	权重
脉弦	0.1586
胀满(闷)或胀痛或窜痛(胸胁、少腹、乳房等)	0.1492
情志抑郁	0.1156
脉沉弦	0.0967
舌质淡红	0.092
急躁易怒	0.0853
苔薄白	0.0808
太息	0.0779
咽喉异物感	0.0531
月经不调	0.0461
痛经	0.0448

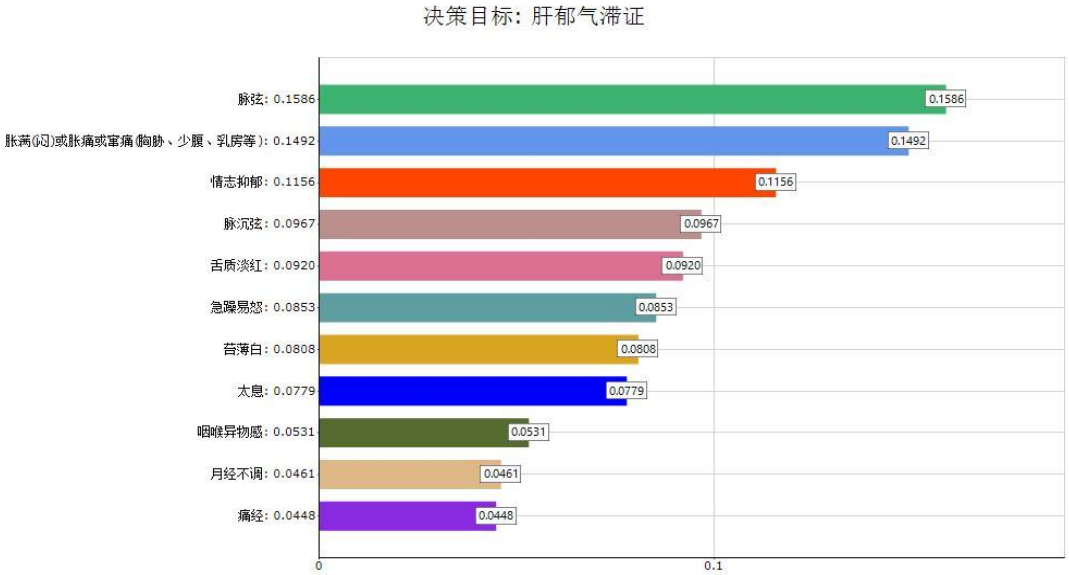

图 10　肝郁气滞证第Ⅱ层专家群权重决策结果

肝郁气滞证专家群决策结果表明：层次分析法两两比较后，专家群决策权重大于 0.1 的四诊指标分别为：脉弦、胀满(闷)或胀痛或窜痛(胸胁、少腹、乳房等)、情志抑郁，大于 0.08 的四诊指标：脉沉弦、舌质淡红、急躁易怒、苔薄白；太息、咽喉异物感四诊指标的权重均大于 0.05；其余四诊指标的权重较小。

3.6 胃肠气滞证专家群决策层次分析结果

分析最后一轮的专家咨询结果，共咨询了 37 位专家。每位专家都对胃肠气滞证辨证诊断的各个层次进行了两两比较，专家群决策决策结果如下：

3.6.1 胃肠气滞证专家群决策层次模型树和权重分析结果

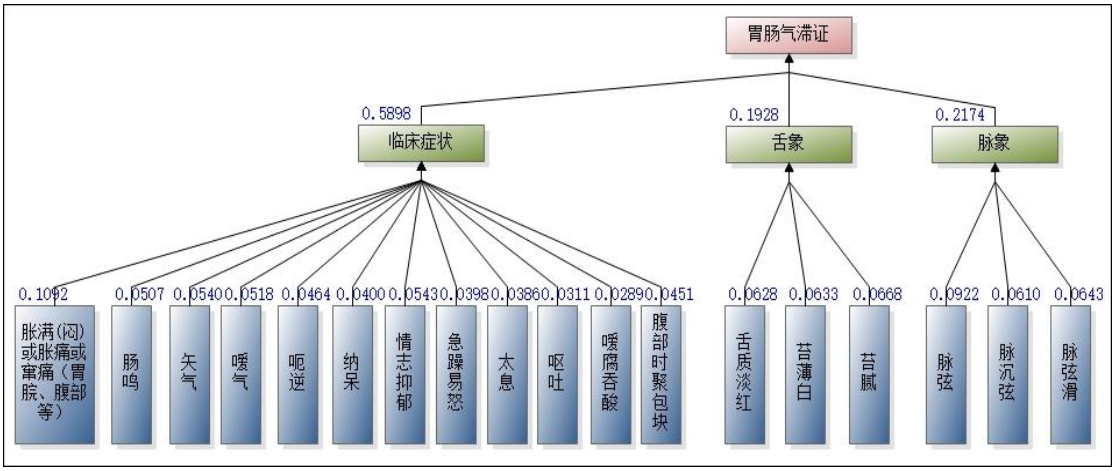

图 11　胃肠气滞证专家群层次分析结果

从图 11 中可以看出层次分析方案层（即中医四诊）和中间层（临床症状、舌象与脉象）均进行了赋权，专家群决策层次模型树的权重可作为胃肠气滞证量化诊断的依据。

3.6.2 胃肠气滞证专家群对中间层临床症状、舌象和脉象权重决策结果

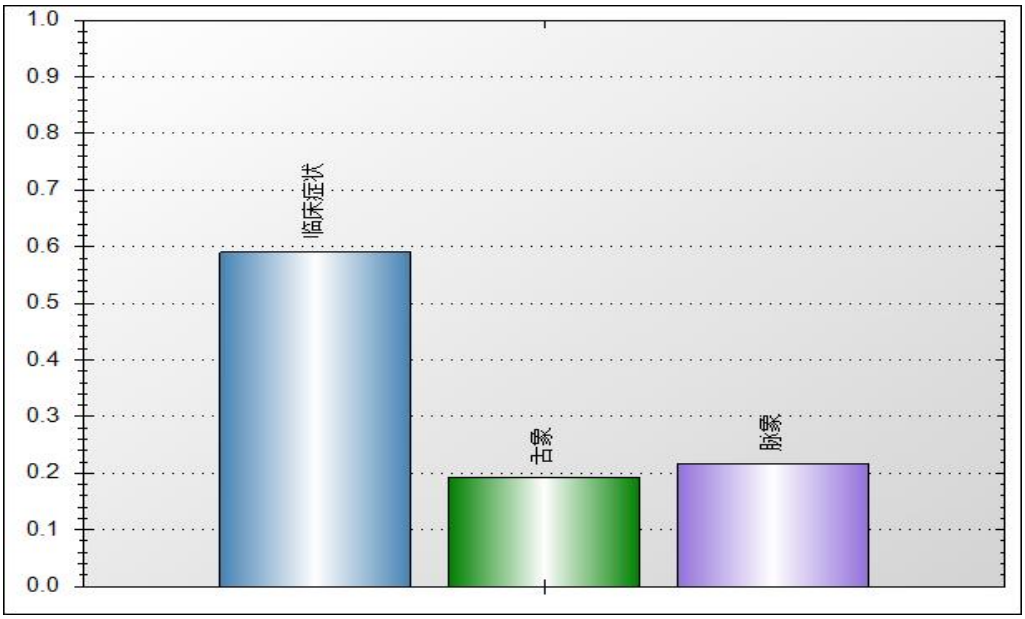

图 12　胃肠气滞证第 I 层专家群权重决策结果

从图 12 中可以看出中间层专家群决策临床症状权重比舌象和脉象大，提示临床症状在辨证时可能更重要一些。

3.6.3 胃肠气滞证四诊专家群决策权重分析比较结果

表 22　胃肠气滞证第 II 层各指标专家群权重决策比较结果

备选方案	权重
胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘、腹部等）	0.1092
脉弦	0.0922

苔腻	0.0668
脉弦滑	0.0643
苔薄白	0.0633
舌质淡红	0.0628
脉沉弦	0.061
情志抑郁	0.0543
矢气	0.054
嗳气	0.0518
肠鸣	0.0507
呃逆	0.0464
腹部时聚包块	0.0451
纳呆	0.04
急躁易怒	0.0398
太息	0.0386
呕吐	0.0311
嗳腐吞酸	0.0289

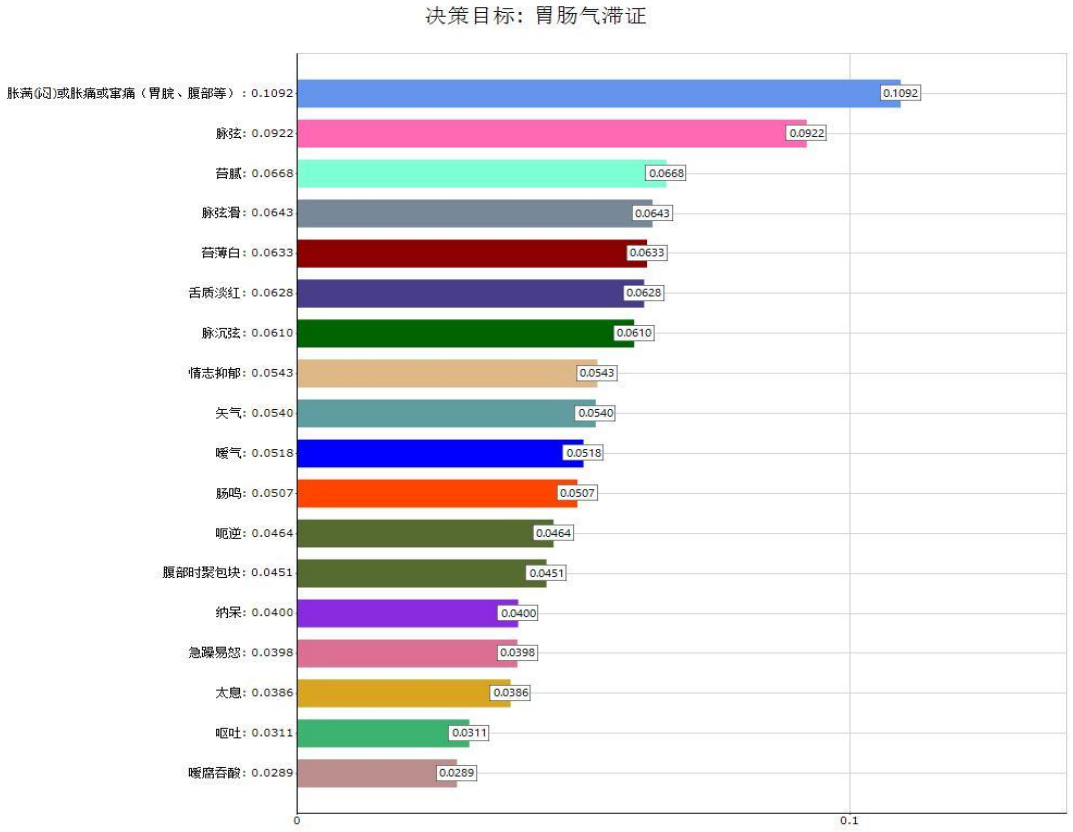

图 13　胃肠气滞证第Ⅱ层专家群权重决策结果

胃肠气滞证专家群决策结果表明：层次分析法两两比较后，专家群决策权重大于 0.1 的四诊指标分别为：胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘、腹部等）；大于 0.08 的四诊指标脉弦；大于 0.05 的四诊指标：苔腻、脉弦滑、苔薄白、舌质淡红、脉沉弦、情志抑郁、矢气、嗳气、肠鸣；呃逆、腹部时聚包块、纳呆四诊指标的权重均大于 0.04；其余四诊指标的权重较小。

3.7 心脉气滞证专家群决策层次分析结果

分析最后一轮的专家咨询结果，共咨询了 37 位专家。每位专家都对心脉气滞证辨证诊断的各个层次进行了两两比较，专家群决策决策结果如下：

3.7.1 心脉气滞证专家群决策层次模型树和权重分析结果

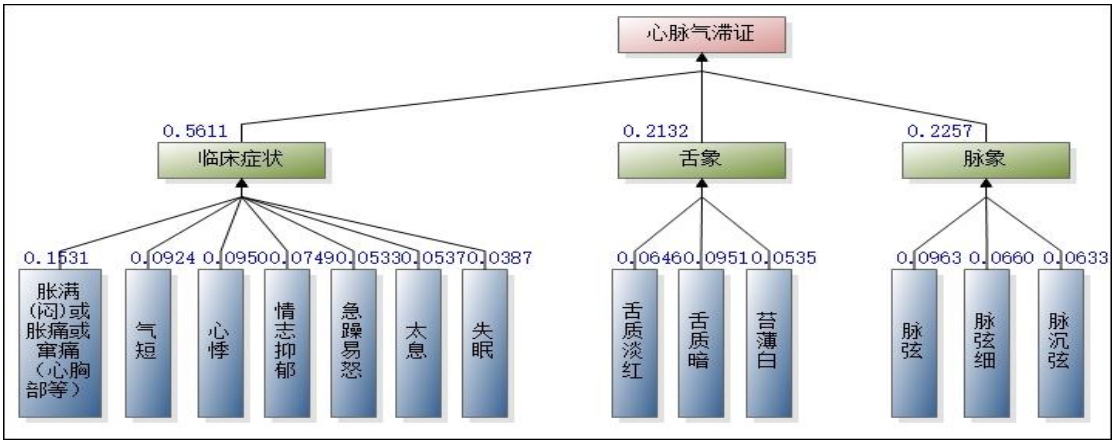

图 14　心脉气滞证专家群层次分析结果

从图 14 中可以看出层次分析方案层（即中医四诊）和中间层（临床症状、舌象与脉象）均进行了赋权，专家群决策层次模型树的权重可作为心脉气滞证量化诊断的依据。

3.7.2 心脉气滞证专家群对中间层临床症状、舌象和脉象权重决策结果

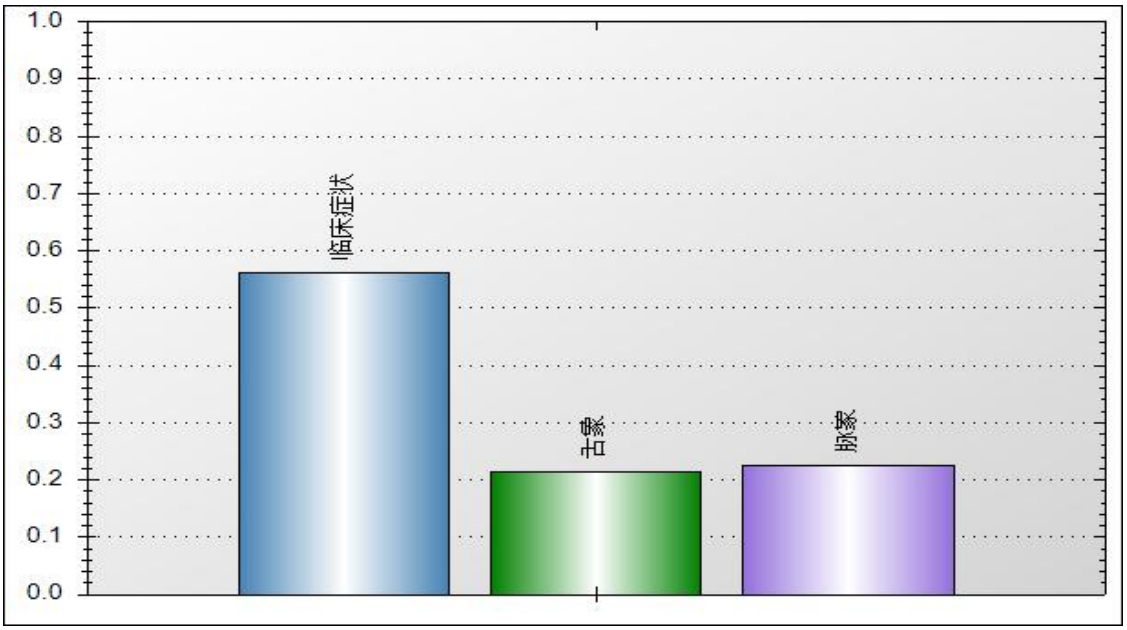

图 15　心脉气滞证第 I 层专家群权重决策结果

从图 15 中可以看出中间层专家群决策临床症状权重比舌象和脉象大，提示临床症状在辨证时可能更重要一些。

3.7.3 心脉气滞证四诊专家群决策权重分析比较结果

表 23　心脉气滞证第Ⅱ层各指标专家群权重决策比较结果

备选方案	权重
胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）	0.1531
脉弦	0.0963
舌质暗	0.0951
心悸	0.095
气短	0.0924
情志抑郁	0.0749
脉弦细	0.066
舌质淡红	0.0646
脉沉弦	0.0633
太息	0.0537
苔薄白	0.0535
急躁易怒	0.0533
失眠	0.0387

图 16　心脉气滞证第Ⅱ层专家群权重决策结果

心脉气滞证专家群决策结果表明：层次分析法两两比较后，专家群决策权重大于 0.1 的四诊指标分别为：胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）；大于 0.08 的四诊指标：脉弦、舌质暗、心悸、气短；除了失眠，其余指标均大于 0.05。

3.8 肺气郁滞证专家群决策层次分析结果

分析最后一轮的专家咨询结果，共咨询了 37 位专家。每位专家都对肺气郁滞证诊断的各个层次进行了两两比较，专家群决策决策结果如下：

3.8.1 肺气郁滞证专家群决策层次模型树和权重分析结果

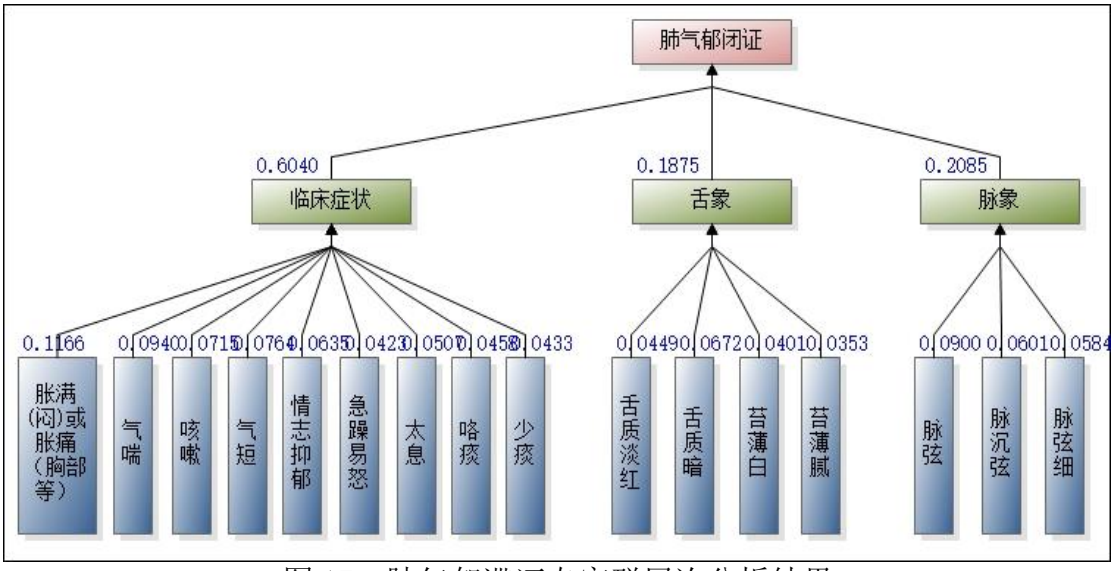

图 17　肺气郁滞证专家群层次分析结果

从图 17 中可以看出层次分析方案层（即中医四诊）和中间层（临床症状、舌象与脉象）均进行了赋权，专家群决策层次模型树的权重可作为肺气郁滞证量化诊断的依据。

3.8.2 肺气郁滞证专家群对中间层临床症状、舌象和脉象权重决策结果

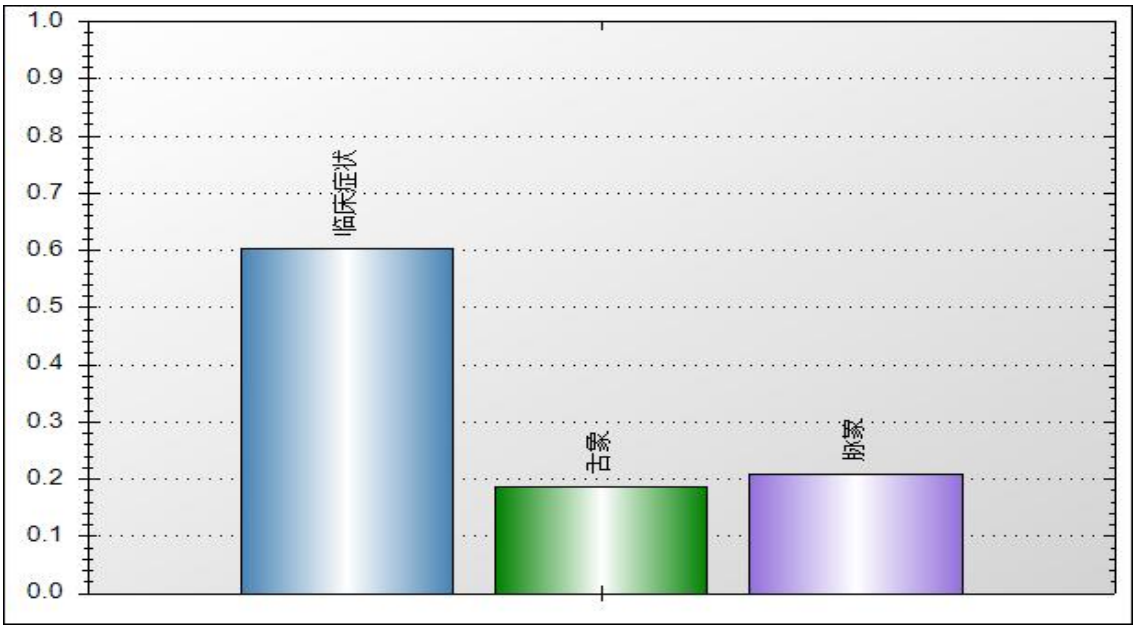

图 18　肺气郁滞证第 I 层专家群权重决策结果

从图 18 中可以看出中间层专家群决策临床症状权重比舌象和脉象大，提示临床症状在辨证时可能更重要一些。

3.8.3 肺气郁滞证四诊专家群决策权重分析比较结果

表 24　肺气郁滞证第 II 层各指标专家群权重决策比较结果

备选方案	权重
胀满(闷)或胀痛（胸部等）	0.1166
气喘	0.094
脉弦	0.09
气短	0.0764
咳嗽	0.0715
舌质暗	0.0672
情志抑郁	0.0635
脉沉弦	0.0601
脉弦细	0.0584
太息	0.0507
咯痰	0.0458
舌质淡红	0.0449
少痰	0.0433
急躁易怒	0.0423
苔薄白	0.0401
苔薄腻	0.0353
胀满(闷)或胀痛（胸部等）	0.1166

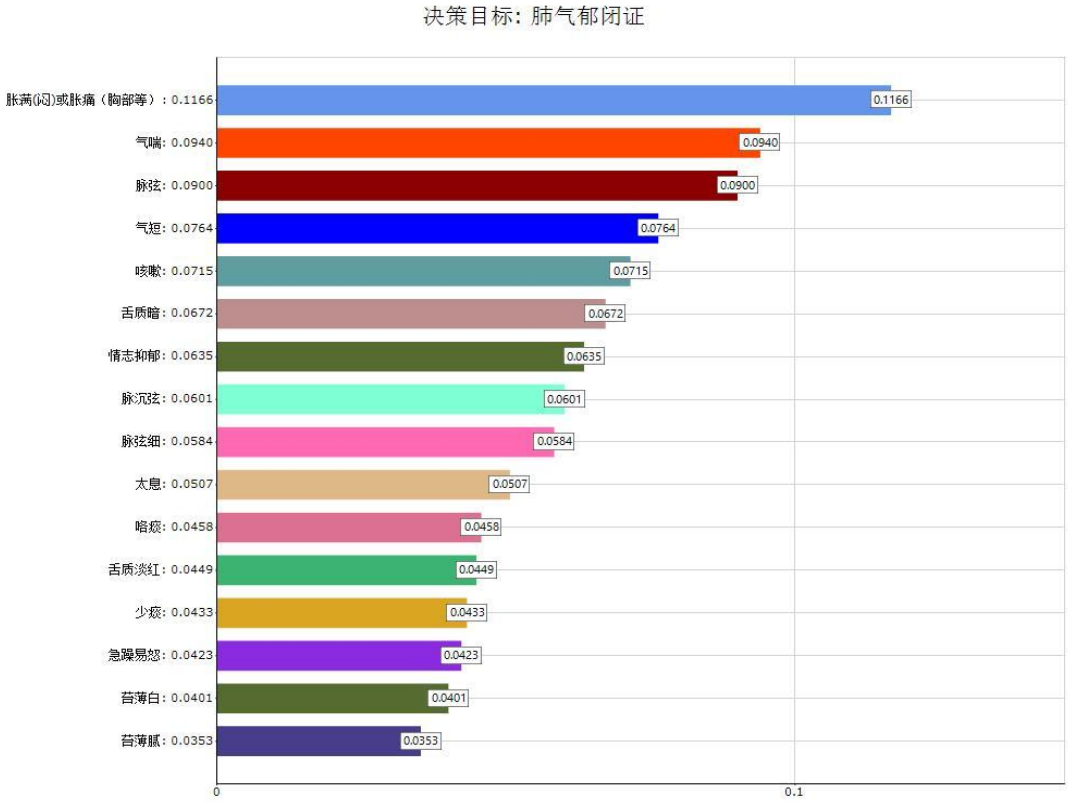

图 19　肺气郁滞证第Ⅱ层专家群权重决策结果

肺气郁滞证专家群决策结果表明：层次分析法两两比较后，专家群决策权重大于 0.1 的四诊指标分别为：胀满(闷)或胀痛(胸部等)；大于 0.08 的四诊指标：气喘、脉弦；大于 0.05 的四诊指标：舌质暗、情志抑郁、脉沉弦、脉弦细、太息；除了苔薄腻，其余四诊指标的权重均大于 0.04。

小结：

结合专家群决策和每位专家对气滞证及其亚型证层次两两比较，气滞证及其亚型证诊断标准的权重指标，分别如下：

① 气滞证

主要条目：胀满(闷)或胀痛或窜痛（7 分）；

次要条目：情志抑郁（4 分），急躁易怒（3 分），太息（3 分）；

舌象：舌质淡红（3 分），苔薄白（2 分）；

脉象：脉弦（5 分），脉沉弦（3 分）。

② 肝郁气滞证

主要条目：胀满(闷)或胀痛或窜痛(胸胁、少腹、乳房等)（4 分），情志抑郁（3 分），急躁易怒（3 分），太息（2 分）；

次要条目：咽喉异物感（2 分），月经不调（1 分），痛经（1 分）；

舌象：舌质淡红（3 分），苔薄白（2 分）；

脉象：脉弦（5 分），脉沉弦（3 分）。

③胃肠气滞证

主要条目：胀满(闷)或胀痛或窜痛（3 分），矢气（2 分），嗳气（2 分），肠鸣（2 分），呃逆（1 分），纳呆（1 分）；

次要条目：情志抑郁（2 分），腹部时聚包块（1 分），急躁易怒（1 分），太息（1 分），呕吐（1 分），嗳腐吞酸（1 分）；

舌象：舌质淡红（2 分），苔薄白（2 分），苔腻（2 分）；

脉象：脉弦（3 分），脉弦滑（2 分），脉沉弦（2 分）。

④心脉气滞证

主要条目：胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）（5 分），心悸（3 分），气短（3 分）；

次要条目：情志抑郁（2 分），急躁易怒（2 分），太息（2 分），失眠（1 分）；

舌象：舌质暗（3 分），舌质淡红（2 分），苔薄白（2 分）；

脉象：脉弦（3 分），脉弦细（2 分），脉沉弦（2 分）。

⑤肺气郁滞证

主要条目：胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸部等）（3 分），气喘（3 分），咳嗽（2 分），气短（2 分）；

次要条目：情志抑郁（2 分），太息（2 分），急躁易怒（1 分），咯痰（1 分），少痰（1 分）；

舌象：舌质暗（2 分），舌质淡红（1 分），苔薄白（1 分），苔薄腻（1 分）；

脉象：脉弦（3 分），脉弦细（2 分），脉沉弦（2 分）。

3.9 专家访谈

（1）访谈方案确定过程及方法

描述访谈专家访谈方案是如何确定的，包括受访专家的选择、访谈专家数量的确定、访谈提纲的起草等。

根据三轮德尔菲专家问卷明确气滞证诊断的条目和权重，初步形成诊断标准的雏形。项目组于 2021 年 8 月～9 月选择全国各地专家进行专家访谈，此次研究选择长期在临床工作中从事中医及中西医结合治疗精神科、妇科、乳腺科等医学行业的 10 名专家。

（2）受访专家名单

建议表格的形式列出，见表 25。

表 25 专家访谈受访专家名单

姓名	单位	职务/职称	专业
李艳	广东省中医院	主任医师	精神心理科
李剑	阜阳市第三人民医院/阜阳市精神卫生中心	副主任医师	中西医治疗精神心理疾病
林洁	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	中医妇科学
郜洁	广州中医药大学第一附属医院	主任医师	中医药防治女性生殖健康与生殖障碍
付娜	首都医科大学附属北京中医医院	副主任医师	中医外科学乳腺专业
周军怀	三亚市中医院	主任医师	消化（脾胃）与老年心脑血管病方向
查安生	安徽中医药大学第一附属医院	主任医师	消化科
戴小华	安徽中医药大学第一附属医院	主任医师	中医内科学（心血管方向）
殷拥军	成都中医药大学附属医院	副主任医师	中西医结合心血管
金朝晖	湖南中医药大学第一附属医院	主任医师	呼吸科

（3）访谈提纲：

《气滞证及其亚型证诊断标准》制定

专家访谈提纲

尊敬的专家：

您好！感谢您参与《气滞证及其亚型证诊断标准》制定的专家访谈。本次调查主要是对气滞证及其亚型证诊断标准的条目进行评价，请您就访谈中有关诊断

的技术流程、条目筛选、条目定义、初步结果及其他方面的等内容进行评价。

（1）气滞证诊断标准

准则层	指标层（评分）
主要条目	胀满(闷)或胀痛或窜痛（6）
次要条目	情志抑郁（3）、遇情志不遂时易诱发或加重（3）、急躁易怒（2）、太息（2）
舌象	舌质淡红（3）、苔薄白（2）
脉象	脉弦（5）、脉沉弦（3）

（2）肝郁气滞证诊断标准

准则层	指标层（评分）
主要条目	胀满(闷)或胀痛或窜痛(胸胁、少腹、乳房等)（4）、情志抑郁（3）、遇情志不遂时易诱发或加重（2）、急躁易怒（2）、太息（2）
次要条目	咽喉异物感（1）、月经不调（1）、痛经（1）
舌象	舌质淡红（3）、苔薄白（2）
脉象	脉弦（5）、脉沉弦（3）

（3）胃肠气滞证诊断标准

准则层	指标层（评分）
主要条目	胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘、腹部等）（3）、矢气（2）、嗳气（1）、肠鸣（1）、呃逆（1）、纳呆（1）
次要条目	情志抑郁（1）、腹部时聚包块（1）、遇情志不遂时易诱发或加重（1）、急躁易怒（1）、太息（1）、呕吐（1）、嗳腐吞酸（1）
舌象	舌质淡红（2）、苔薄白（2）、苔腻（2）
脉象	脉弦（3）、脉弦滑（2）、脉沉弦（2）

（4）心脉气滞证诊断标准

准则层	指标层（评分）
主要条目	胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）（4）、心悸（3）、气短（3）
次要条目	情志抑郁（2）、遇情志不遂时易诱发或加重（2）、急躁易怒（1）、太息（1）、失眠（1）
舌象	舌质暗（3）、舌质淡红（2）、苔薄白（2）
脉象	脉弦（3）、脉弦细（2）、脉沉弦（2）

（5）肺气郁滞证诊断标准

准则层	指标层（评分）
主要条目	胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸部等）（3）、气喘（3）、咳嗽（2）、气短（2）
次要条目	情志抑郁（2）、遇情志不遂时易诱发或加重（2）、太息（1）、急躁易怒（1）、咯痰（1）、少痰（1）
舌象	舌质暗（2）、舌质淡红（1）、苔薄白（1）、苔薄腻（1）
脉象	脉弦（3）、脉弦细（2）、脉沉弦（2）

本标准预计采用的诊断模式：

（1）主要条目满足 1 条、次要条目满足 1 条、同时具备舌象或脉象其中 1 条，即可建立气滞证及其亚型证的诊断；

（2）各条目权重分算数和达到阈值 X，即可建立气滞证及其亚型证的诊断。(X 值由临床试用后确定)。

本次访谈主要内容：

（1）您对研究工作的认可程度与建议，包括技术流程、条目筛选、初步结果；

（2）您对主要条目、次要条目、舌象、脉象中各条目的术语规范、条目取舍的意见与建议；

（3）对气滞证及其亚型证诊断模式的意见与建议。

访谈细则	认可度
技术流程	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10
条目筛选	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10
条目定义	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10
初步结果	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10
诊断模式	□0 □1 □2 □3 □4 □5 □6 □7 □8 □9 □10
访谈建议	

访谈提纲至此结束，本资料收回。

（4）气滞证团体标准制定专家访谈会议合影

（5）访谈结论

表 26　气滞证诊断标准访谈结论汇总表

序号	意见内容	提出意见专家	处理意见
1	气滞证应该是一个大类的证型。肝郁、胃肠、心脉等其他应是在此大类下细分	林洁、殷拥军、金朝晖、陈家旭	采纳 将细分的亚型证合并到气滞证大类的兼证条目。
2	增加情志抑郁在兼证诊断标准中的分值比重，临床接触的相关患者中，除少数重症抑郁，情感丧失的患者，大多数患者在主诉中均会以情志抑郁为一项主要主诉	李剑	采纳 提高情志方面的诊断比重
3	肝郁气滞证诊断标准中可考虑增加饮食大便情况，如脘闷、嗳气、不思饮食、大便不调等作为一项次要条目	李剑	采纳 脘闷已存在主要条目中，将“嗳气、不思饮食、大便不调”加入次要条目
4	“次要条目满足 1 条”改为“次要条目满足 2 条”	李艳	部分采纳 修改至“主要条目满足 1 条、次要条目满足 2 条”或“主要条目满足 2 条、次要条目满足 1 条”
5	“痛经”涵盖在“少腹痛”的条目中	郜洁	未采纳 “少腹痛”不能解释“痛经”的状态，故分开论述
6	在肝郁气滞证型次要条目中添加：失眠；在心脉气滞证型次要条目中添加：憋气；在肺气郁滞证型次要条目中添加：劳累	付娜	部分采纳 添加失眠、憋气至肝郁气滞证、肺气郁滞证中，劳累作为一种诱发因素，未纳入此次诊断标准
7	妇科方面的条目，应备注与男性不相关	周军怀	采纳 已在月经不调和痛经后面加入与男性不相关的描述

8	诊断模式修改，增加“主要条目满足 1 条、次要条目满足 1 条”或“主要条目满足 2 条”则可成立诊断	周军怀	部分采纳 修改至“主要条目满足 1 条、次要条目满足 2 条”或“主要条目满足 2 条、次要条目满足 1 条”
9	“苔腻”需定性明确，例如苔薄腻、苔黄腻、苔白腻、苔厚腻，个人推荐“苔薄腻”	查安生	采纳 “苔腻”修改至“苔薄腻”
10	肺气郁滞证中常见“少痰、气促”	查安生、金朝晖	采纳 已添加“少痰、气促”至肺气郁滞证
11	心脉气滞证表现为心胸部疼痛表述为“刺痛”比“胀痛”更贴切一些。	戴小华	采纳 “胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）”改为“胀满(闷)或刺痛或窜痛（心胸部等）”
12	心脉气滞症多合并淤血等症，脉多见涩等，建议可再脉诊上加上	殷拥军	未采纳 涩脉常见于血瘀证
13	亚型证可单独作为证型成立	陈家旭	采纳
14	赋权需分为轻中重 3 等分	李先涛	采纳

（七）达成共识

本研究根据文献研究后，采用三轮德尔菲专家咨询方法收集专家对条目的意见，待条目确定后，运用层次分析法为每个条目权重赋值，并通过专家访谈对最终的诊断模式进行修订。通过三轮交流和专家访谈（表 27-28）和两轮研讨会会议（见附件 6），最终使专家意见趋于一致，形成气滞证诊断标准的专家共识。

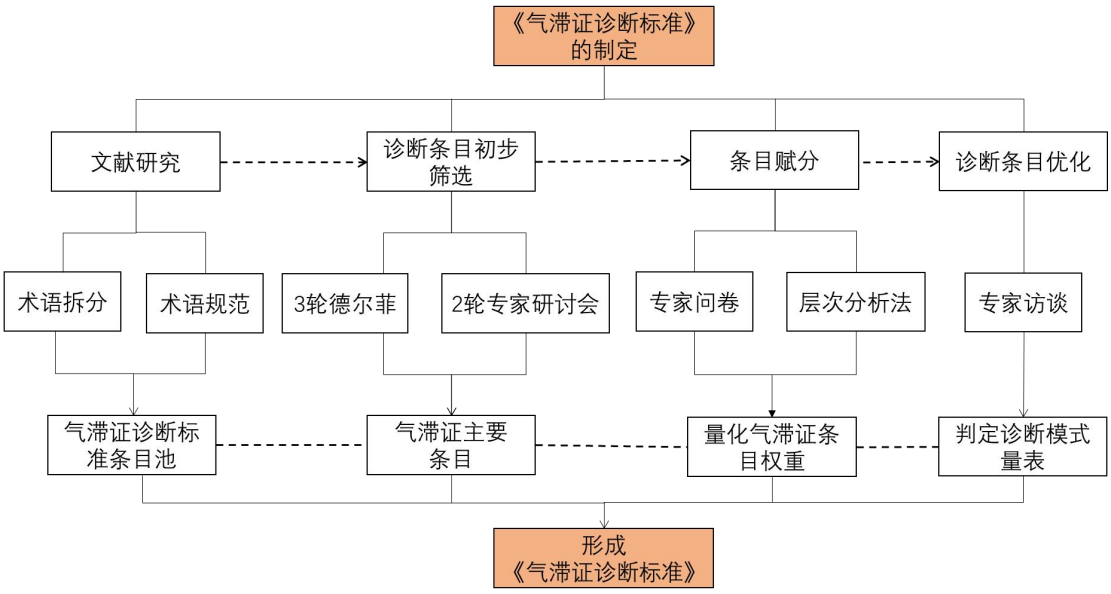

图 20　气滞证诊断标准流程图

表 27　气滞证诊断标准达成共识汇总表

	文献研究	专家咨询（三轮）			专家访谈
		第一轮调查	第二轮调查	第三轮调查	
调查目的	√界定气滞证专业内涵（性质、功能、部位） √结构化集成气滞证辨证依据集	√逻辑穷举、补充完善气滞证辨证依据 √气滞证标准判定形式摸底	√气滞证诊断构成【共性/兼证】调查 √进一步筛选、优化【共性/兼证】指标	√明确气滞证标准的诊断模式进一步明确【共性/兼证】指标	√明确气滞证标准的诊断模式
调查内容	√气滞证核心症状、体征、舌象、脉象（诊断指标）	√指标描述、重要性、熟悉程度及指标补充	√指标主症/次症/舌象/脉象分级	√诊断模式调查	√诊断模式调查 √诊断标准的判定形式
调查方法	√文献结合专家讨论	√问卷调查+会议调查	√问卷调查+会议调查	√问卷调查	√线上+线下结合访谈
文献/专家概况	√气滞证相关证候资料，肝郁气滞证98篇文献和49本书籍;胃肠气滞证58篇文献和62本书籍；心脉气滞证70篇文献和25本书籍；肺气郁滞证38篇文献和13本书籍；工具书8本	√来源：全国各省市 √专业范畴：中西医结合肝病、中西医结合心血管疾病的防治研究、中西医结合脾胃病、中西医结合呼吸与危重症医学、中医药治疗神经系统疾病的基础与临床、中医妇科学、中医内科学、中医诊断学、中医四诊信息化及证候基础研究 √参与调查人数：15人	√来源：全国各省市 √专业范畴：中西医结合肝病、中西医结合心血管疾病的防治研究、中西医结合脾胃病、中西医结合呼吸与危重症医学、中医药治疗神经系统疾病的基础与临床、中医妇科学、中医乳腺科、中医内科学、中医诊断学、中医四诊信息化及证候基础研究、量表研制 √参与调查人数：32人	√来源：全国各省市 √专业范畴：中西医结合肝病、中西医结合心血管疾病的防治研究、中西医结合脾胃病、中西医结合呼吸与危重症医学、中医药治疗神经系统疾病的基础与临床、中西医结合精神病学、中医妇科学、中医乳腺科、中医内科学、中医诊断学、中医四诊信息化及证候基础研究、量表研制、中医药膳学 √参与调查人数：37人	√来源：全国各省市 √专业范畴：中西医治疗精神心理疾病、中医药防治女性生殖健康与生殖障碍、中医外科学乳腺专业、消化（脾胃）与老年心脑血管病方向、呼吸内科 √参与调查人数：10人
结果/结论概况	√通过文献研究，术语规范，获得气滞证相关症状139项，经小组内讨论及临床专家核心小组咨询，最终获得气滞证核心症状42项，为后续专家咨询提供本地资料。	√新增4项症状 √修改6项症状表述 √探索新的更贴合临床实际的诊断方法	√删除指标14项 √获得共性指标9项，兼证指标23项 √共性和兼证判定形式获得大多数专家认可、支持	√条目指标稳定 √采用共性/兼证的诊断模式	√新增指标3项 √删除1项 √获得共性指标5项，兼证指标21项，舌象4项，脉象4项 √采用共性/兼证/舌象/脉象的诊断模式 √明确了具体的标准判定形式

表 28　气滞证诊断标准研制条目汇总表

序号	文献调查	第一轮专家咨询	结果	第二轮专家咨询	结果	第三轮专家咨询	结果	专家访谈	结果
	气滞证核心症状	重要性、熟悉度、判断依据	/	主症/次症/舌象/脉象	/	主症/次症/舌象/脉象	/	共性/兼证	/
	本地资料	摸底、穷举	/	初筛	/	稳定	/	优化	/
气滞证	胀闷疼痛	胀闷疼痛	改-胀窜满闷痛	胀窜满闷痛	改-胀满(闷)或胀痛	胀满(闷)或胀痛或窜痛	主症	胀满(闷)或胀痛或窜痛	共性
	情志抑郁	情志抑郁	保留	情志抑郁	主症	情志抑郁	次症	情志抑郁	共性
	急躁易怒	急躁易怒	保留	急躁易怒	主症	急躁易怒	次症	急躁易怒	共性
	症状随情绪波动加重	症状随情绪波动加重	情志不遂时易诱发或	遇情志不遂时易诱发或加重	主症	情志不遂时易诱发或加	主症	情志不遂时易诱发或加	共性
	太息	太息	保留	太息	次症	太息	次症	太息	共性
	舌质淡红	舌质淡红	保留	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象
	/	/	新增-舌质暗	舌质暗	删除	/	/	/	/
	苔薄白	苔薄白	保留	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象
	苔薄黄	苔薄黄	保留	苔薄黄	删除	/	/	/	/
	脉弦	脉弦	保留	脉弦	脉象	脉弦	脉象	脉弦	脉象
	/	/	新增-脉沉弦	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象
肝郁气滞证	胀窜闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	胀窜闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	闷痛（胸胁、少腹、	满闷痛（胸胁、少腹、乳房	主症	痛或窜痛（胸胁、少腹	主症	痛或窜痛（胸胁、少	共性
	情志抑郁	情志抑郁	保留	情志抑郁	主症	情志抑郁	主症	情志抑郁	共性
	急躁易怒	急躁易怒	保留	急躁易怒	主症	急躁易怒	主症	急躁易怒	共性
	症状随情绪波动加重	症状随情绪波动加重	保留	遇情志不遂时易诱发或加重	主症	情志不遂时易诱发或加	主症	情志不遂时易诱发或加	共性
	太息	太息	保留	太息	主症	太息	主症	太息	共性
	咽喉异物感	咽喉异物感	保留	咽喉异物感	次症	咽喉异物感	次症	咽喉异物感	兼证
	痛经	痛经	保留	痛经	次症	痛经	次症	痛经（与男性无关）	兼证
	月经不调	月经不调	保留	月经不调	次症	月经不调	次症	经不调（与男性无关	兼证
	失眠	失眠	保留	失眠	删除	/	/	失眠	兼证-新增
	矢气	矢气	保留	矢气	删除	/	/	/	/
	大便不调	大便不调	改-大便秘结	大便秘结	删除	/	/	大便秘结	兼证-新增
	纳呆	纳呆	保留	纳呆	删除	/	/	纳呆	兼证-新增
	舌质淡红	舌质淡红	保留	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象
	舌红	舌红	删除	/	/	/	/	/	/
	/	/	新增-舌质暗	舌质暗	舌象	舌质暗	删除	/	/
	苔薄白	苔薄白	保留	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象
	苔薄黄	苔薄黄	保留	苔薄黄	删除	/	/	/	/
	脉弦	脉弦	保留	脉弦	脉象	脉弦	脉象	脉弦	脉象
	/	/	新增-脉沉弦	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象
胃肠气滞证	胃脘或腹部胀满疼痛	胃脘或腹部胀满疼痛	满闷痛（胃脘、腹	胀窜满闷痛（胃脘、腹部等）	主症	胀痛或窜痛（胃脘部、	主症	胀痛或窜痛（胃脘部	共性
	/	/	新增-情志抑郁	情志抑郁	主症	情志抑郁	次症	情志抑郁	共性
	/	/	新增-急躁易怒	急躁易怒	主症	急躁易怒	次症	急躁易怒	共性
	/	/	情志不遂时易诱发	遇情志不遂时易诱发或加重	主症	情志不遂时易诱发或加	主症	情志不遂时易诱发或加	共性
	肠鸣	肠鸣	保留	肠鸣	主症	肠鸣	主症	肠鸣	兼证
	矢气	矢气	保留	矢气	主症	矢气	主症	矢气	兼证
	嗳气	嗳气	保留	嗳气	主症	嗳气	主症	嗳气	兼证
	呃逆	呃逆	保留	呃逆	主症	呃逆	主症	呃逆	兼证
	/	/	新增-太息	太息	次症	太息	次症	太息	共性
	纳呆	纳呆	保留	纳呆	次症	纳呆	主症	纳呆	兼证
	嗳腐吞酸	嗳腐吞酸	保留	嗳腐吞酸	次症	嗳腐吞酸	次症	嗳腐吞酸	兼证
	恶心呕吐	恶心呕吐	改-呕吐	呕吐	次症	呕吐	次症	呕吐	兼证
	大便不调	大便不调	改-腹泻	腹泻	删除	/	/	/	/
	口苦	口苦	保留	口苦	删除	/	/	/	/
	/	/	新增-腹部时聚包块	腹部时聚包块	次症	腹部时聚包块	次症	腹部时聚包块	兼证
	咽干	咽干	删除	/	/	/	/	/	/
	舌红	舌红	删除	/	/	/	/	/	/
	舌质淡红	舌质淡红	保留	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象
	舌质暗	舌质暗	保留	舌质暗	删除	/	/	/	/
	苔薄白	苔薄白	保留	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象
	苔薄黄	苔薄黄	保留	苔薄黄	删除	/	/	/	/
	苔腻	苔腻	保留	苔腻	舌象	苔腻	舌象	苔腻	舌象
	苔白	苔白	保留	苔白	删除	/	/	/	/
	脉弦	脉弦	保留	脉弦	脉象	脉弦	脉象	脉弦	脉象
	脉沉弦	脉沉弦	保留	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象
	脉弦滑	脉弦滑	保留	脉弦滑	脉象	脉弦滑	脉象	脉弦滑	脉象
	脉弦细	脉弦细	删除	/	/	/	/	/	/
心脉气滞证	胸部憋闷或胀痛	胸部憋闷或胀痛	窜满闷痛（心胸部	胀窜满闷痛（心胸部等）	主症	闷)或胀痛或窜痛（心胸	主症	)或胀痛或窜痛（心胸	共性
	/	/	新增-情志抑郁	情志抑郁	主症	情志抑郁	次症	情志抑郁	共性
	心情抑郁或心烦	心情抑郁或心烦	改-急躁易怒	急躁易怒	主症	急躁易怒	次症	急躁易怒	共性
	症状随情绪波动加重	症状随情绪波动加重	保留	遇情志不遂时易诱发或加重	主症	情志不遂时易诱发或加	主症	情志不遂时易诱发或加	共性
	气短	气短	保留	气短	主症	气短	主症	气短	兼证
	心悸	心悸	保留	心悸	主症	心悸	主症	心悸	兼证
	/	/	新增-太息	太息	次症	太息	次症	太息	共性
	失眠	失眠	保留	失眠	次症	失眠	次症	失眠	兼证
								憋气	兼证-新增
	头痛	头痛	保留	头晕	删除	/	/	/	/
	头晕	头晕	保留	头痛	删除	/	/	/	/
	乏力	乏力	保留	乏力	删除	/	/	/	/
	矢气	矢气	删除	/	/	/	/	/	/
	舌质淡红	舌质淡红	保留	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象
	舌质暗	舌质暗	保留	舌质暗	舌象	舌质暗	舌象	舌质暗	舌象
	苔薄白	苔薄白	保留	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象
	苔薄黄	苔薄黄	保留	苔薄黄	删除	/	/	/	/
	苔腻	苔腻	保留	苔腻	删除	/	/	/	/
	脉弦	脉弦	保留	脉弦	脉象	脉弦	脉象	脉弦	脉象
	脉弦细	脉弦细	保留	脉弦细	脉象	脉弦细	脉象	脉弦细	脉象
	/	/	新增-脉沉弦	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象
肺气郁滞证	胸闷	胸闷	窜满闷痛（胸背部	胀窜满闷痛（胸背部等）	主症	闷)或胀痛或窜痛（胸部	主症	闷)或胀痛或窜痛（胸	共性
	情志抑郁	情志抑郁	保留	情志抑郁	主症	情志抑郁	次症	情志抑郁	共性
	急躁易怒	急躁易怒	保留	急躁易怒	主症	急躁易怒	次症	急躁易怒	共性
	症状随情绪波动加重	症状随情绪波动加重	情志不遂时易诱发	遇情志不遂时易诱发或加重	主症	情志不遂时易诱发或加	主症	情志不遂时易诱发或加	共性
	喘息上气	喘息上气	保留	喘息上气	改-气喘	气喘	主症	气喘	兼证
	咳嗽	咳嗽	保留	咳嗽	主症	咳嗽	主症	咳嗽	兼证
	气短	气短	保留	气短	主症	气短	主症	气短	兼证
	/	/	新增-太息	太息	次症	太息	次症	太息	共性
	咽有梗阻感	咽有梗阻感	改-咽喉异物感	咽喉异物感	次症	/	/	/	/
	咯痰	咯痰	保留	咯痰	次症	咯痰	次症	咯痰	兼证
	少痰	少痰	保留	少痰	次症	少痰	次症	少痰	兼证
								气促	兼证-新增
	咽干	咽干	保留	咽干	次症	/	/	/	/
	失眠	失眠	保留	失眠	次症	/	/	/	/
	纳呆	纳呆	删除	/	/	/	/	/	/
	舌质淡红	舌质淡红	保留	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象	舌质淡红	舌象
	/	/	新增-舌质暗	舌质暗	舌象	舌质暗	舌象	舌质暗	舌象
	舌红	舌红	保留	舌红	舌象	/	/	/	/
	苔薄白	苔薄白	保留	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象	苔薄白	舌象
	苔薄黄	苔薄黄	保留	苔薄黄	舌象	/	/	/	/
	苔白	苔白	保留	苔白	舌象	/	/	/	/
	/	/	新增-苔薄腻	苔薄腻	舌象	苔薄腻	舌象	苔薄腻	舌象
	脉弦	脉弦	保留	脉弦	脉象	脉弦	脉象	脉弦	脉象
	脉弦细	脉弦细	保留	脉弦细	删除	/	/	/	/
	/	/	新增-脉沉弦	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象	脉沉弦	脉象
	脉浮	脉浮	删除	/	/	/	/	/	/

（八）撰写标准草案

在上述研究基础上，项目组执笔人胡志希、陈家旭、李先涛、方格、周旋、范星宇、谭朵廷、谈宇权、廉坤、廖晓倩、蒋浩波、张君宇、王啸轶、胡慧玲于 2022 年 4 月完成标准草案的编制，并根据专家意见进行了对标准进行了修正，形成《气滞证诊断标准（草案）》。

（九）征求意见

工作组将指南征求意见稿和编制说明等材料通过电子邮件和短信的方式向全国来自不同领域的专家开展征求意见工作。

序号	意见内容	提出意见专家	处理意见
1	未教授改为：为教授； 按姓氏笔划排序改为按姓氏笔画排序。	刘林、车志英、王少贤	采纳。已修改。
2	个人建议更换为证候的 4 个亚型。	岳利峰	不采纳。 本标准建立的是一个整体的气滞证，亚型证可在本标准建立后，将考虑建立 4 个亚型证。
3	肺气郁滞证输入重复。	岳利峰	采纳。已删除。
4	这个表可能只适用于气滞证的诊断。建议若是进一步直接能把肝郁气滞证、胃肠气滞证、心脉气滞证、肺气郁滞证在此表中明确诊断出来可能更好，最好在这个标准里有体现。	车志英	不采纳。 本标准整体的气滞证诊断标准，脏腑辨证肝郁气滞证等包含在其中。本标准发布后，将考虑进一步细化脏腑辨证的工作。
5	建议此标准制定好后，直接做个软件，规则写进软件，用这个软件即可判断证型。	车志英	采纳。 标准成立后将进一步深化研究。
6	气滞进一步发展会形成气滞血瘀、.....建议增加气机闭阻。	张华	采纳。已修改。
7	在文字描述上，存在极少量可优化的细节，详见修订模式。“stagnation”首字母大写;“并为其始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准缺如，”改为“可作为始发证和基本证，常伴随疾病始终，但诊断标准阙如”;“附录 A”是否需要统一标点的半角和全角？	张军峰	采纳。已修改。
8	多见于许多重大疾病和慢性疾病。	陈剑华	采纳。已修改。
9	引言：为避免个人因素对辨证的干扰，提高临床诊疗和临床科研辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床与科研气滞证辨证的准确性和规范性。 建议改为：为了提高中医临床辨证的准确性和一致性，结合国内外最新证候及相关术语研究进展，特制定本标准，指导临床疾病气滞证辨证的准确性和规范	刘文兰	采纳。已修改。

	性。		
10	″引言：本文件基于中医气滞证理论的气滞（为核心病机）和特征性舌脉象， 建议改为：本文件基于文献研究、专家调查及中医病因病机″。	刘文兰、岳利峰	采纳。已修改。
11	″特制定本标准，指导临床与科研气滞证辨证的准确性和规范性。 建议修改为：特制定本标准，指导临床与科研工作中气滞证辨证的准确性和规范性。″	王利敏	采纳。已修改。
12	诊断依据和诊断标准， 建议修改为：诊断标准和依据。	陈剑华	采纳。已修改。
13	规范性引用文件，这部分应该是相应的标准，有文件号。	王泓午	采纳。已添加文件号。
14	气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞，运行不畅所出现的证候。改为：气滞证指人体某一脏腑、经络或某一部位的气机郁滞，运行不畅所出现的证候。	陈云志	采纳。已修改。
15	气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞所出现的证候。删除“运行不畅”。	刘林	不采纳。 气的功能是运动的，主要表现形式已升降出入为主，气机郁滞则会出现运行不畅。因此，需要纳入“运行不畅”。
16	本标准适用于全国各级医疗机构及科研院所专业人员对气滞证的临床诊断。	岳利峰	采纳。 修改为：本标准适用于全国各级医疗机构及教学科研院所专业人员对气滞证的诊断。
17	去除“气郁证”。	岳广欣	不采纳。 《GB/T 16751.2-2021 中医证候诊疗术语·证候》有说明。
18	“气滞进一步发展会形成气滞血瘀”建议改为“气滞证进一步发展会形成气滞血瘀”。	赵歆	采纳。已修改。
19	气滞证指人体某一部位或某一脏腑、经络的气机郁滞，运行不畅所出现的证候。 建议修改为：气滞证指人体某一脏腑、经络气机郁滞、运行不畅所出现某一部位胀闷窜痛等为主要表现的证候。	刘文兰	采纳。已修改。
20	情志抑郁是否要细化下时间病程？ 急躁易怒解释为“心情急躁，容易发怒。” 建议修改为“性格急躁，容易发	陈剑华	不采纳。 偶尔的情绪异常为正常人的表现；急躁易怒是情绪方面症状，改为“情绪急躁，容易发怒”。

	怒。”		
21	咽部异物感：常见描述为咯/咳之不出，咽之不下，建议核对。	富文俊	采纳。已修改。
22	肝郁气滞证，需增加“经间期出血”、阳痿或疝气（男性）。	薛飞飞、陈云志	不采纳。 没有文献和前期专家的提议。
23	月经不调，期、量、色、质的异常，应该涉及色质的描述以及闭经的情况。	张华	采纳.已添加色质的描述以及闭经的情况。
24	太息的概念建议参考十四五规划教材《中医诊断学》。	赵歆、林雪娟	采纳。已修改。
25	纳呆：进食量的欲望减退，改：进食欲望或/和进食量减退； 肠鸣，肠蠕动亢进而漉漉有声的表现，建议加上部位，腹部漉漉； 呕吐，后面的有物无声，有声无物之分感觉可以删去。	张华	采纳。已修改。
26	去掉“症状”二字，或移至结尾处。	薛飞飞	采纳。已修改。
27	“便次减少，便质干燥，或”不一定都干燥，建议删去。	赵歆	不采纳。专家推荐的是十二五规划教材，此条术语的释义基于最新的十四五规划教材中医诊断学。
28	“连续不断的症状”改为“表现”； 上文呕吐分别将二字解释，此处咳与嗽未分别解释，建议前后统一。	赵歆	采纳。已修改。
29	气滞证的气短感觉需要注释下和气虚证气短鉴别开来。	岳利峰	已加入说明，“常兼有呼吸声粗，或胸部窒闷，或胸腹胀满等”。
30	气短更强调一种自己的感觉，气短不足以息，未必一定有呼吸急促之象。	张华	采纳。已修改。
31	憋气：删除。	陈云志	采纳。已删除。
32	是否需细化说明包含早醒？	陈剑华	不采纳。 术语解释中的“睡而易醒，难以复睡”为早醒的描述。
33	“气喘”是否合适？气喘去掉“短促”；太息是否改为“善太息”。	赵歆、薛飞飞、汪南玥	不采纳。 气喘可因气机阻滞，肺失宣降所致。术语的定义立足最新的十四五规划教材而来。
34	薄白苔 thin, white coating “舌苔薄白润泽，颗粒均匀，薄薄铺于舌面，揩之不去。”建议修改为“舌苔薄薄一层分布于舌面，透过舌苔可以看到舌体，揩之不去。” 弦脉 string pulse “脉势紧张，端直以长，如按琴	李福凤	采纳。已修改。

	弦。”建议修改为“端直以长，如按琴弦。”		
35	共性条目 1.建议将胀闷、胀痛分为两个条目。	张华	不采纳。 条目解释用的“或”连接的。
36	1. 胀满(闷)或胀痛或窜痛。建议这样改：胀满(闷)或胀痛或窜痛(备注：病位胸胁、少腹、乳房等明显，多见于肝郁气滞证；胸腹部等明显，多见于胃肠气滞证；心胸部等明显，多见于心脉气滞证；胸部等明显，多见于肺气郁滞证)； 2. 胀满(闷)或胀痛或窜痛条目下的概念：身体某些部位出现疼痛，疼痛部位走窜不定，且伴有胀感或郁闷不舒感。建议加上仅有胀感或郁闷不舒感。	车志英、张华	1.采纳。添加部位的描述。 2.不采纳。根据文献数据表明，疼痛的表现也有体现。临床上是有程度上的差异，轻型气机阻滞以胀满或胀闷为主，重型气机阻滞可出现疼痛感。
37	共性症状 2：遇情志不遂时易诱发或加重：建议修改为：遇情志不遂时易诱发或加重，常随心情愉悦、嗳气、矢气等而减轻。	刘文兰	采纳。已修改。
38	1.共性条目的 2 3 移至“兼证条目”“肝郁气滞证”； 2.共性条目 2、3、4、5 不应作为气滞证共性条目，当补充气滞证的共性条目内容； 3.太息、急躁易怒两项是否不适合放在共性症状中，应该放在肝郁气滞中，肝气滞中的嗳气、纳呆、便秘等应该放在胃肠中；气短仅放在心脉中，肺中仅放气促； 4.肝郁气滞证：(4) 嗳气、(5) 纳呆、(6) 大便秘结、(7) 失眠：这几个症状不一定属于肝郁气滞，只能说肝郁气滞可以进一步引起这些症状，属于继发性症状。	岳广欣、唐涛、张华、刘文兰	1.采纳。共性条目 3“情志抑郁”已移至“肝郁气滞证”中。 2.不采纳。根据十四五规划教材中医诊断学，气滞证表现含有共性条目 2“遇情志不遂时易诱发或加重，随心情愉悦、嗳气、矢气等减轻”。
39	建议将(2) 月经不调（与男性无关）和(3) 痛经（与男性无关）合并为一条改为：妇女有月经不调、痛经，经前乳房胀痛。	程良斌、李晓红	采纳。已修改。
40	肝郁气滞证建议删除“失眠”、“大便秘结”。	刘林 陈云志、程良斌	采纳。已修改。
41	增加面容憔悴，手足不温。	李晓红	不采纳。 1.没有文献和前期专家的提议； 2.手足不温重点不在气滞，在阳虚、寒凝中常见。

42	肝郁气滞证症状积分在男女方面是否有所区别，积分总数一致。	汪南玥	本研究是客观化主症+次症的诊断方法，与积分在性别上无差异。
43	胃肠气滞证增加大便秘结，指大便干结或大便次数减少或大便不畅。	李晓红	采纳。已添加。
44	胃肠气滞证中去除“嗳腐吞酸”。	岳广欣	采纳。已删除。
45	胃肠气滞证是否应该细化拆分出肝胃不和证。	周雪明	不采纳。本修订的胃肠气滞证，其中主要症状描述的是胃肠部气机运行不畅的表现，同时将肝脏部位出现的症状已删除。
46	兼证条目的分型是否更全面更细化一些，如肝脾气滞证、气滞胃脘证、小肠气滞证等。	王宇红	不采纳。本研究是从常见的脏腑肝、胃肠、心、肺收集气滞证的诊断标准，本标准发布后，将考虑进一步细化的工作。
47	气滞证表现：心悸，建议改为惊悸。	张华	不采纳。惊悸是因惊而导致悸动，不属于气滞证范畴。
48	心脉气滞证的失眠：不应纳入。	陈云志、刘文兰	不采纳。根据文献研究及专家调查，失眠属于心脉气滞证的范畴。
49	肺气郁滞证：咳痰，少痰不应纳入。	陈云志、刘文兰、金朝晖	采纳。已删除。
50	舌象保留 2 去除 1 3 4；1.淡红舌 3.薄白苔 4.薄腻苔不反映气滞，易造成无效得分，干扰结论。	岳广欣、贺娟、林雪娟、刘文兰	采纳。已删除。
51	“沉弦脉”建议改为“沉脉”；〞脉象条目“1.弦脉 2.沉弦脉 3.弦滑脉 4.弦细脉” 建议修改为经典的“弦脉”。〞	贺娟、刘文兰、程绍民、刘林、岳广欣	采纳。弦脉、沉脉保留。
52	增加结脉。	李晓红	不采纳。结脉在临床上不常见。
53	脉象赋份宜改为 2 分。	黄世敬	采纳。已修改。
54	“临床见上述指标累计赋分＞16 分者可诊断为气滞证”，可否将此累计赋分改大，如≥20 分？	王宇红	不采纳。 1.本研究是客观化主症+次症的诊断方法，分值大的是主症，分值低的是次症，例如，共性条目 6 分/项，兼证条目 4 分/项。同一条目中有多个症状或体征同时出现，仅按 1 项计分； 2.阈值的客观判定方式是：“共性条目 1 条+兼证条目 2 条+舌象或脉象 1 条”或“共性条目 2 条+兼证条目 1 条+舌象或脉象 1 条”，阈值范围[16-18]分，方便计数，选择低分 16 分作为阈值分。
55	参考书籍引用格式或标点符号不正确，例如引用书籍需添加地	王少贤、王利敏、张北平	采纳。已修改。

	名，应统一引用格式以及标点符号。		
56	建议制作系列疾病中气滞证的诊断规范短视频，有利于面向患者和社会进行中医诊断规范化科普。	张军峰	采纳。已修改。

四、与国内外同类标准的对比和最新标准采用情况

（一）描述国内外是否有已发布且正在实施中的同领域标准？本标准与其相比，有什么区别？

本标准制订过程中，尚无同领域标准。

（二）是否引用相关标准？引用的内容是什么？

无。

五、与现行强制性国家标准或政策法规的关系

与现行强制性国家标准及政策法规没有矛盾或冲突。

六、代表性分歧意见的处理经过和依据

本标准在文献调研完成以后，制订了专家问卷调查，采用德尔菲法、层次分析法、专家访谈征求专家意见，专家基本认可标准中的内容，对标准中涉及的具体条目及诊断阈值等提出了自己的意见和建议。项目工作组对标准进行了修改形成标准草案，经多轮专家论证会论证形成初稿，项目工作组通过向同行专家征求意见，修改标准初稿，最终形成了标准核心工作组审核稿，报送专家指导组审核。

七、宣传、贯彻标准和后效评价标准的要求和措施

（一）宣传、贯彻标准的措施

1. 标准的实施单位

（1）通过中华中医药学会等中医药学会平台发布和公告，使本标准具有权威性。

（2）通过中医药相关网站、微信平台发布，提供用户免费下载权限，以方便用户更准确了解、应用本标准。

（3）将在中华中医药学会中药临床药理分会、世界中医药学会联合会临床疗效评价专业委员会举办相关的学术会议上，可利用制定本标准的首席专家和项目专家的学术影响力报告本标准具体内容、制定过程、应用范例等，使与会人员了解本标准及应用情况。同时将邀请媒体进行播报，以扩大本标准的影响力。

2. 其他宣传、贯彻本标准的措施

（1）课题组将继续在国内外核心期刊、专业报纸上就标准研制的意义、编制过程、临床适用性等问题发表 1-2 篇中文核心文章。另将指导在读研究生将本标准的具体内容及应用范例等纳入学位论文中，并授权中国知网、万方等数据库公开发表，使读者对本标准有全面了解。

（2）未来两年内，拟对全国华北、华中、华南 3 个片区 5 个省、自治区、直辖市的 5 家临床研究分中心的临床医师和科研人员进行培训，累计达 200 人。同时拟对上述 5 家临床调查研究单位科研人员就本标准的制定、意义、应用进行 1 次专题培训，预计参会人员将超过 100 人。计划召开 1 次针对西医医院精神科临床医生的专题培训或研讨会，对本标准的中医辨证内容进行重点讲解，以进一步扩大本标准的应用面，预计参会人员将达到 50 人。围绕本标准制定过程，拟开展层次分析法方法学培训 1 次，供科研人员及在读研究生参考，预计参会人员 150 人。

（二）标准的用户评价

项目计划在 2023-2024 两年内，在全国各省、自治区、直辖市的全国各级医院精神科、脾胃科、乳腺科、妇科、心血管科及其他呼吸科疾病相关科室的临床医护人员，以及从事抑郁症、慢性非萎缩性胃炎等相关疾病研究的科研院所专业人员，进行气滞证诊断标准的用户评价。

（三）标准的修订

本标准计划 5 年后进行更新，更新方案主要涉及临床推荐强度。

八、废止现行有关标准的建议

无。

九、相关附录

附件 1：《气滞证诊断标准》立项公告

附件 2：《气滞证及其亚型证诊断标准》第一轮德尔菲专家问卷

附件 3：《气滞证及其亚型证诊断标准》第二轮德尔菲专家问卷

附件 4：《气滞证及其亚型证诊断标准》第三轮德尔菲专家问卷

附件 5：《气滞证及其亚型证诊断标准》层次分析法专家咨询

附件 1 《气滞证诊断标准》立项公告

中 华 中 医 药 学 会

中华中医药学会团体标准

立 项 公 告

China Association of Chinese Medicine

Announcement for Standards

中华中医药学会批准《气滞证诊断标准》立项，现予公告。

The T/CACM standard for Diagnostic Criteria on Syndrome of Qi Stagnation was initiated by the China Association of Chinese Medicine, and now it is effective.

中华中医药学会

China Association of Chinese Medicine

2020 年 11 月 16 日

附件 2 《气滞证及其亚型证诊断标准》第一轮德尔菲专家问卷

《气滞证及其亚型证诊断标准》第一轮德尔菲专家问卷

一、气滞证[1]辨证条目[2]

（术语编号：4.10；释义：某些脏腑或局部气机阻滞，以胸胁脘腹胀闷疼痛，时轻时重，走窜不定，胀痛常随太息、嗳气、肠鸣、矢气而减，脉弦为常见症的证候。）

气滞证诊断备选条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
一、主症																	
1. 情志抑郁或急躁易怒	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2. 胀闷疼痛（胸胁、脘腹、乳房、少腹等）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
3. 太息	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
4. 症状随情绪波动加重	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
二、次症																	
5. 肠鸣	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
6. 矢气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
7. 嗳气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

[1] 证候名、术语编号及释义均来源于：中华人民共和国国家标准：中医临床诊疗术语(证候部分)

[2] 条目形成参考课题组文献系统评价结果。

8.纳呆	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
9.失眠	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
10.大便不调（便溏或便秘）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
11.月经不调	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
12.嘈杂	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
13.咽喉异物感	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
14.头晕	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
三、舌象																	
15.无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
四、脉象																	
16.脉弦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您认为上述 16 个症状和体征的表述哪些需要修改？																	
条目：　　应表述为：																	
条目：　　应表述为：																	
请问：除上述 16 个症状和体征指标外，您认为能够帮助气滞证诊断成立的四诊信息**还有哪些**？他们重要性如何？																	
补充条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
1.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

2.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您对我们的《气滞证辨证条目》还有什么其他意见或建议？																	
1.																	
2.																	

二、肝郁气滞证[3]辨证条目

（术语编号：9.8；释义：肝失疏泄，气机郁滞，以情志抑郁，喜叹息，胸胁或少腹胀闷窜痛，妇女乳房胀痛，月经不调，脉弦等为常见症的证候。）

肝郁气滞证诊断备选条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
一、主症																	
1. 情志抑郁或急躁易怒	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2. 胀窜闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
3. 太息	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
4. 症状随情绪波动加重	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
二、次症																	
5. 咽喉异物感	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
6. 纳呆	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
7. 失眠	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

[3] 证候名、术语编号及释义均来源于：中华人民共和国国家标准：中医临床诊疗术语(证候部分)

8.大便不调（便溏或便秘）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
9.矢气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
10.痛经	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
11.月经不调	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
三、舌象																	
12.舌红	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
13.无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
四、脉象																	
14.脉弦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您认为上述 14 个症状和体征的表述哪些需要修改？																	
条目：　　应表述为：																	
条目：　　应表述为：																	
请问：除上述 14 个症状和体征指标外，您认为能够帮助肝郁气滞证诊断成立的四诊信息**还有哪些**？他们重要性如何？																	
补充条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
1.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您对我们的《肝郁气滞证辨证条目》还有什么其他意见或建议？																	

1.
2.

三、胃肠气滞证[4]辨证条目

(术语编号：8.77；释义：胃肠气机阻滞，以胃脘或腹部痞胀、胀痛或窜痛，得嗳气、肠鸣、矢气而觉舒，脉弦等为常见症的证候)

胃肠气滞证诊断备选条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
一、主症																	
1. 胃脘或腹部胀满疼痛	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2. 嗳气或呃逆	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
3. 肠鸣	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
4. 矢气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
二、次症																	
5. 纳呆	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
6. 嗳腐吞酸	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
7. 大便不调（便溏或便秘）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
8. 恶心呕吐	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
9. 口苦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

[4] 证候名、术语编号及释义均来源于：中华人民共和国国家标准：中医临床诊疗术语(证候部分).

10.咽干	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
三、舌象																	
11.舌红	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
12.舌质暗	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
13.苔腻	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
14.苔白	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
15.无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
四、脉象																	
16.脉弦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
17.脉沉	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
18.脉细	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
19.脉滑	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您认为上述 19 个症状和体征的表述哪些需要修改？																	
条目：　　应表述为：																	
条目：　　应表述为：																	
请问：除上述 19 个症状和体征指标外，您认为能够帮助胃肠气滞证诊断成立的四诊信息**还有哪些**？他们重要性如何？																	
补充条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻

1.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您对我们的《胃肠气滞证辨证条目》还有什么其他意见或建议？																	
1.																	
2.																	

四、心脉气滞证[5]辨证条目

（术语编号：6.17；释义：心脉气机阻滞，以胸闷、心胸胀痛或窜痛，脉弦等为常见症的证候）

心脉气滞证诊断备选条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
一、主症																	
1. 胸部憋闷或胀痛	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2. 气短	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
3. 心情抑郁或心烦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
4. 失眠	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
5. 症状随情绪波动加重	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
二、次症																	
6. 心悸	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
7. 头晕	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

[5] 证候名、术语编号及释义均来源于：中华人民共和国国家标准：中医临床诊疗术语(证候部分)

8.头痛	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
9.乏力	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
10.矢气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
三、舌象																	
11.舌质暗	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
12.苔腻	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
13.无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
四、脉象																	
14.脉弦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
15.脉细	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您认为上述 15 个症状和体征的表述哪些需要修改？																	
条目：　　应表述为：																	
条目：　　应表述为：																	
请问：除上述 15 个症状和体征指标外，您认为能够帮助心脉气滞证诊断成立的四诊信息**还有哪些**？他们重要性如何？																	
补充条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
1.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

问题：您对我们的《心脉气滞证辨证条目》还有什么其他意见或建议？
1.
2.

五、肺气郁滞证[6]辨证条目

（术语编号：7.40；释义：气机郁滞，肺失宣降，以情志抑郁，胸闷咳嗽等为主症的证候）

肺气郁滞证诊断备选条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻
一、主症																	
1. 胸闷	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2. 咳嗽	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
3. 喘息上气	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
4. 气短	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
5. 症状随情绪波动加重	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
二、次症																	
6. 情志抑郁或急躁易怒	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
7. 咯痰	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
8. 少痰	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1

[6] 证候名、术语编号及释义均来源于：中华人民共和国国家标准：中医临床诊疗术语(证候部分)

9.咽干	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
10.咽有梗阻感	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
11.失眠	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
12.纳呆	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
三、舌象																	
13.舌红	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
14.苔白	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
15.无明显舌象变化（舌淡红，苔薄白或薄黄）	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
四、脉象																	
16.脉弦	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
17.脉细	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
18.脉浮	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您认为上述 18 个症状和体征的表述哪些需要修改？																	
条目：　　应表述为：																	
条目：　　应表述为：																	
请问：除上述 18 个症状和体征指标外，您认为能够帮助肺气郁滞证诊断成立的四诊信息**还有哪些**？他们重要性如何？																	
补充条目	重要性评价（请在相应位置“√”）					您对该条目熟悉程度					您的判断依据				您对该条目等级划分		
	非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要	很熟悉	较为熟悉	一般熟悉	不太熟悉	不熟悉	临床经验	理论分析	国内外同行了解	直观感觉	重	中	轻

1.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
2.	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□0	□4	□3	□2	□1	□3	□2	□1
问题：您对我们的《肺气郁滞证辨证条目》还有什么其他意见或建议？																	
1.																	
2.																	

附件 3 《气滞证及其亚型证诊断标准》第二轮德尔菲专家问卷

《气滞证及其亚型证诊断标准》第二轮德尔菲专家问卷

一、气滞证辨证标准

条目	是否入选气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1. 胀窜满闷痛	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2. 情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3. 急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4. 遇情志不遂时易诱发或加重	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
二、次症							
5. 太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
6. 舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7. 舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8. 苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9. 苔薄黄	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
10. 脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
判断依据							
气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉 □较为熟悉 □一般熟悉 □不太熟悉 □不熟悉						
气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验 □理论分析 □国内外同行了解 □直观感觉						

二、肝郁气滞证辨证条目

条目	是否入选肝郁气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1. 胀窜满闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2. 情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3. 急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

4. 遇情志不遂时易诱发或加重	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5. 太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
二、次症							
6. 咽喉异物感	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7. 痛经	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8. 月经不调	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9. 失眠	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10. 矢气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11. 大便秘结	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12. 纳呆	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
13. 舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
14. 舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15. 苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
16. 苔薄黄	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
17. 脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
肝郁气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
肝郁气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

三、胃肠气滞证辨证条目

条目	是否入选胃肠气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1. 胀窜满闷痛（胃脘、腹部等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2. 情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3. 急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4. 遇情志不遂时易诱发或加重	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5. 肠鸣	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6. 矢气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

7. 嗳气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8. 呃逆	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
二、次症							
9. 太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10. 纳呆	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11. 嗳腐吞酸	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12. 呕吐	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
13. 腹泻	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
14. 口苦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15. 腹部时聚包块	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
16. 舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
17. 舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
18. 苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
19. 苔薄黄	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
20. 苔腻	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
21. 苔白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
22. 脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
23. 脉沉	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
24. 脉滑	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
胃肠气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
胃肠气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

四、心脉气滞证辨证条目

条目	是否入选心脉气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1. 胀窜满闷痛（心胸部等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2. 情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3. 急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

4. 遇情志不遂时易诱发或加重	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5. 气短	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6. 心悸	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
二、次症							
7. 太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8. 失眠	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9. 头晕	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10. 头痛	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11. 乏力	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
12. 舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
13. 舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
14. 苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15. 苔薄黄	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
16. 苔腻	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
17. 脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
18. 脉细	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
判断依据							
心脉气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉 □较为熟悉 □一般熟悉 □不太熟悉 □不熟悉						
心脉气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验 □理论分析 □国内外同行了解 □直观感觉						

五、肺气郁滞证辨证条目

条目	是否入选肺气郁滞证诊断条目	重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
		非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症						
1. 胀窜满闷痛（胸背部等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2. 情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3. 急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4. 遇情志不遂时易诱发或加重	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5. 喘息上气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

6. 咳嗽	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7. 气短	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
二、次症							
8. 太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9. 咽喉异物感	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10. 咯痰	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11. 少痰	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12. 咽干	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
13. 失眠	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
14. 舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15. 舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
16. 舌红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
17. 苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
18. 苔薄黄	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
19. 苔白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
20. 脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
21. 脉细	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
肺气郁滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉 □较为熟悉 □一般熟悉 □不太熟悉 □不熟悉
肺气郁滞证辨证条目的判断依据	□临床经验 □理论分析 □国内外同行了解 □直观感觉

附件 4 《气滞证及其亚型证诊断标准》第三轮德尔菲专家问卷

《气滞证及其亚型证诊断标准》第三轮德尔菲专家问卷

一、气滞证辨证标准

条目	是否入选气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
是否在主症中加入“遇情志不遂时易诱发或加重”的描述？	□是	□否					
二、次症							
2.情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3.急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4.太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
5.舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6.苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
7.脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8.脉沉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉 □较为熟悉 □一般熟悉 □不太熟悉 □不熟悉
气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验 □理论分析 □国内外同行了解 □直观感觉

二、肝郁气滞证辨证条目

条目	是否入选肝郁气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸胁、少腹、乳房等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2.情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3.急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4.太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
是否在主症中加入“遇情志不遂时易诱发或加重”的描述？	□是	□否					
二、次症							
5.咽喉异物感	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6.痛经	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7.月经不调	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
8.舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9.舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10.苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
11.脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12.脉沉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
肝郁气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
肝郁气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

三、胃肠气滞证辨证条目

条目	是否入选胃肠气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛(胸胁、少腹、乳房等)	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2.肠鸣	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3.矢气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4.嗳气	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5.呃逆	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6.纳呆	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
是否在主症中加入“遇情志不遂时易诱发或加重”的描述？	□是	□否					
二、次症							
7.情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8.急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9.太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10.呕吐	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11.嗳腐吞酸	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12.腹部时聚包块	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
13.舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
14.苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15.苔腻	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
16.脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
17.脉沉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
18.脉弦滑	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
胃肠气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
胃肠气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

四、心脉气滞证辨证条目

条目	是否入选心脉气滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2.气短	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3.心悸	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
是否在主症中加入“遇情志不遂时易诱发或加重”的描述？	□是	□否					
二、次症							
4.情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
5.急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6.太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7.失眠	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
8.舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9.舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
10.苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
11.脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12.脉弦细	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
13.脉沉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
心脉气滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
心脉气滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

五、肺气郁滞证辨证条目

条目	是否入选肺气郁滞证诊断条目		重要性评价（请在相应位置“√”）（选“否”，则不进行条目评分）				
			非常重要	比较重要	一般重要	较不重要	极不重要
一、主症							
1.胀满(闷)或胀痛或窜痛（胸部等）	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
2.气喘	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
3.咳嗽	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
4.气短	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
是否在主症中加入“遇情志不遂时易诱发或加重”的描述？	□是	□否					
二、次症							
5.情志抑郁	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
6.急躁易怒	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
7.太息	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
8.咯痰	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
9.少痰	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
三、舌象							
10.舌质淡红	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
11.舌质暗	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
12.苔薄白	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
13.苔薄腻	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
四、脉象							
14.脉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0
15.脉沉弦	□是	□否	□4	□3	□2	□1	□0

判断依据	
肺气郁滞证辨证的熟悉程度	□很熟悉　□较为熟悉　□一般熟悉　□不太熟悉　□不熟悉
肺气郁滞证辨证条目的判断依据	□临床经验　□理论分析　□国内外同行了解　□直观感觉

附件 5 《气滞证及其亚型证诊断标准》层次分析法问卷

气滞证及其亚型证层次分析法专家咨询判断矩阵

为完成气滞证及其亚型证辨证各层指标的比较，需要您完成以下 5 大问卷表格。

层次分析法是指两个指标相对重要性的比较，文件采用 1-9 标度法。请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比**列指标**	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

注释：**9-1 为重要区间**，数字越大，越重要；**1-1/9 为不重要区间**，数字越小，越次要；1 为**同等**重要。

示例表：临床症状与舌象、脉象之间的重要性比较

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1	1【**临床症状**（行指标）比**舌象**（列指标）**同等**重要】	3【**临床症状**（行指标）比**脉象**（列指标）**略重要**】
舌象		1	3【**舌象**（行指标）比**脉象**（列指标）**略重要**】
脉象			1

注释：①括号内为数字的词语解释，只需填写数字即可。

②所有空格的比较均是：行指标比列指标，**比较不可颠倒**。

③阴影区与空白区的行指标比列指标互为为倒数，因此只需填写空白区。

一、气滞证辨证层次分析法专家咨询判断矩阵

为明确气滞证辨证各层指标权重，需要您对问卷中提到的两个指标的相对重要性加以比较。文件采用 1-9 标度法，请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比列指标	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

表 1-1 气滞证辨证指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1		
舌象		1	
脉象			1

表 1-2 气滞证辨证临床症状指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	胀窜满闷痛	情志抑郁	急躁易怒	遇情志不遂时易诱发或加重	太息
胀窜满闷痛	1				
情志抑郁		1			
急躁易怒			1		
遇情志不遂时易诱发或加重				1	
太息					1

表 1-3 气滞证辨证舌象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	舌质淡红	苔薄白
舌质淡红	1	
苔薄白		1

表 1-4 气滞证辨证脉象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	脉弦	脉沉弦
脉弦	1	
脉沉弦		1

二、肝郁气滞证辨证层次分析法专家咨询判断矩阵

为明确肝郁气滞证辨证各层指标权重，需要您对问卷中提到的两个指标的相对重要性加以比较。文件采用 1-9 标度法，请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比列指标	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

表 2-1 肝郁气滞证辨证指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1		
舌象		1	
脉象			1

表 2-2 肝郁气滞证辨证临床症状指标判断矩阵（阴影区不填）

临床症状指标	胀窜满闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	情志抑郁	急躁易怒	遇情志不遂时易诱发或加重	太息	咽喉异物感	痛经	月经不调
胀窜满闷痛（胸胁、少腹、乳房等）	1							
情志抑郁		1						
急躁易怒			1					
遇情志不遂时易诱发或加重				1				
太息					1			
咽喉异物感						1		
痛经							1	
月经不调								1

表 2-3 肝郁气滞证辨证二级指标舌象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	舌质淡红	舌质暗	苔薄白
舌质淡红	1		
舌质暗		1	
苔薄白			1

表 2-4 肝郁气滞证辨证脉象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	脉弦	脉沉弦
脉弦	1	
脉沉弦		1

三、胃肠气滞证辨证层次分析法专家咨询判断矩阵

为明确胃肠气滞证辨证各层指标权重，需要您对问卷中提到的两个指标的相对重要性加以比较。文件采用 1-9 标度法，请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比列指标	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

表 3-1 胃肠气滞证辨证指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1		
舌象		1	
脉象			1

表 3-2 胃肠气滞证辨证临床症状指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘、腹部等）	肠鸣	矢气	嗳气	呃逆	纳呆	情志抑郁	急躁易怒	遇情志不遂时易诱发或加重	太息	呕吐	嗳腐吞酸	腹部时聚包块
胀满(闷)或胀痛或窜痛（胃脘、腹部等）	1												
肠鸣		1											
矢气			1										
嗳气				1									
呃逆					1								
纳呆						1							
情志抑郁							1						
急躁易怒								1					
遇情志不遂时易诱发或加重									1				
太息										1			
呕吐											1		
嗳腐吞酸												1	
腹部时聚包块													1

表 3-3 胃肠气滞证辨证舌象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	舌质淡红	苔薄白	苔腻
舌质淡红	1		
苔薄白		1	
苔腻			1

表 3-4 胃肠气滞证辨证脉象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	脉弦	脉沉弦	脉弦滑
脉弦	1		
脉沉弦		1	
脉弦滑			1

四、心脉气滞证辨证层次分析法专家咨询判断矩阵

为明确心脉气滞证辨证各层指标权重，需要您对问卷中提到的两个指标的相对重要性加以比较。文件采用 1-9 标度法，请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比列指标	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

表 4-1 心脉气滞证辨证指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1		
舌象		1	
脉象			1

表 4-2 心脉气滞证辨证临床症状指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）	气短	心悸	情志抑郁	急躁易怒	遇情志不遂时易诱发或加重	太息	失眠
胀满(闷)或胀痛或窜痛（心胸部等）	1							
气短		1						
心悸			1					
情志抑郁				1				
急躁易怒					1			
遇情志不遂时易诱发或加重						1		
太息							1	
失眠								1

表 4-3 心脉气滞证辨证舌象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	舌质淡红	舌质暗	苔薄白
舌质淡红	1		
舌质暗		1	
苔薄白			1

表 4-4 心脉气滞证辨证脉象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	脉弦	脉弦细	脉沉弦
脉弦	1		
脉弦细		1	
脉沉弦			1

五、肺气郁滞证辨证层次分析法专家咨询判断矩阵

为明确肺气郁滞证辨证各层指标权重，需要您对问卷中提到的两个指标的相对重要性加以比较。文件采用 1-9 标度法，请在相应的表格填写数字，数字标度的含义及说明如下表：

行指标比列指标	极重要	很重要	重要	略重要	同等	略次要	次要	很次要	极次要
评价	9	7	5	3	1	1/3	1/5	1/7	1/9
备注	取 8,6,4,2,1/2,1/4,1/6,1/8 为上述评价值的中间值								

表 5-1 肺气郁滞证辨证指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	临床症状	舌象	脉象
临床症状	1		
舌象		1	
脉象			1

表 5-2 肺气郁滞证辨证临床症状指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	胀满(闷)或胀痛(胸部等)	气喘	咳嗽	气短	情志抑郁	急躁易怒	遇情志不遂时易诱发或加重	太息	咯痰	少痰
胀满(闷)或胀痛（胸部等）	1									
气喘		1								
咳嗽			1							
气短				1						
情志抑郁					1					
急躁易怒						1				
遇情志不遂时易诱发或加重							1			
太息								1		
咯痰									1	
少痰										1

表 5-3 肺气郁滞证辨证舌象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	舌质淡红	舌质暗	苔薄白	苔薄腻
舌质淡红	1			
舌质暗		1		
苔薄白			1	
苔薄腻				1

表 5-4 肺气郁滞证辨证脉象指标判断矩阵（阴影区不填）

指标	脉弦	脉沉弦
脉弦	1	
脉沉弦		1

附件 6　历次会议纪要

1.专家咨询线上研讨会

时 间： 2021 年 04 月 26 日 19:00-20:30

地 点： 腾讯会议室

https://meeting.tencent.com/s/Re4CZiqtu870

会议 ID：340 618 338

主 持： 胡志希

专 家： 陈家旭（暨南大学）

郭蓉娟（北京中医药大学东方医院）

李先涛（广州中医药大学）

邹小娟（湖北中医药大学）

董昌武（安徽中医药大学）

王忆勤（上海中医药大学）

何建成（上海中医药大学）

郑景辉（广西中医药大学附属瑞康医院）

张诗军（中山大学第一附属医院）

黄绍刚（广东省中医院）

刘　赟（惠爱医院）

朱志敏（惠爱医院）

钟舒明（华侨医院）

喻　斌（湖南中医药大学第一附属医院）

李新纯（湖南省脑科医院）

刘建和（湖南中医药大学第一附属医院）

张　涛（湖南中医药大学第一附属医院）

刘旺华（湖南中医药大学）

简维雄（湖南中医药大学）

丁长松（湖南中医药大学）

列席人员：周旋、李晓娟、李琳、方格、范星宇、廖晓倩、胡慧玲、陈明远、黄淑敏、杨杨、盖亭伊、周耀、雷经纬、臧秋迟、王啸轶、李浩阳、钟森杰、王梓仪、张倩、李昕、熊霞军、闫立彬、余怡嫔、占凯、郑欢

1.1 介绍专家和参会人员

1.2 项目负责人陈家旭教授讲话

1.3 子课题负责人胡志希介绍气滞证团体标准研究进展

1.4 方格博士介绍第一轮专家问卷中医四诊信息的情况

1.5 范星宇硕士汇报理化指标的文献系统评价

1.6 方格博士介绍第一轮专家问卷理化指标的情况

1.7 各位专家发言

（1）郭蓉娟教授

传统气滞证中对情志的描述较少，建议这次标准的制定将情志内容予以补充；对神经递质、内分泌方面的理化研究信息不够全面。

（2）李先涛教授

气滞证是共有的证候，但各亚型中主症的宏观描述与主证有很大差异，差异如何解决？临床验证时需要以量表的形式呈现。量表的指标需根据专家意见予以修改。

（3）邹小娟教授

需要统一亚型证与基础证的主症。临床辨证时较少观察理化指标的变化，相关的结论是通过查阅资料等理论方法推导出的，可能与临床实际有较大差距。

（4）董昌武教授

气滞证需要有共性，其他不同脏腑气滞都应含有气滞证共性的内容；理化指标需慎重纳入。

（5）何建成教授

失眠是否应细化。本团队在做前瞻性研究时，发现冠心病心力衰竭心脉气滞证患者表现出的症状为冠脉痉挛，冠状动脉并没有实质性的损害。病理因素是证型不统一的原因，不仅仅强调辨证论治，还强调辨病论治。

（6）郑景辉教授

文献检索后是否进行了文献质量评价，制定标准不是所有文献都要进行文献质量评价，尤其是诊断性研究（相关网站 https://www.equator-network.org/）。指标是观察性研究，就用 STROBE 评价工具，诊断性研究用 STARD 评价工具。

（7）张诗军教授

脾虚证将唾液淀粉酶作为金指标，因此，理化指标不一定要很多。气滞证研

究中，胃肠气滞与胃动力有关；肝郁气滞证与情绪指标相关，如 5-羟色胺 5-HT。

（8）刘赟教授

临床常见气滞证患者，初期为单纯气滞证，后期多出现化火、生痰、生瘀等变化为气滞的变证，建议应将变证类条目予以排除。肝郁气滞证或气滞证的病人的理化指标在临床上可能观察不到太大的变化。

（9）钟舒明教授

气滞证问卷分型像临床中所见的焦虑症患者，这些患者的病变存在于人体不同的系统中，如胃肠道系统、神经系统、心血管系统等方面。理化指标变化会存在于气滞证患者身上，但这些指标可能没有特异性。临床推广时，需要考虑临床的可操作性，操作不容易，普及性会低。

（10）喻斌教授

标准关键在于指导临床还是指导科研，许多理化指标特异性、敏感性的验证，会使临床的可操作性时间很长。气滞证理化指标多出现在功能性胃肠疾病中，如 5-羟色胺（5-HT）、胃泌素（GAS）等，但这些指标的变化没有特异性；而指标升高降低到哪一个值也很难确定，所以在制定标准过程中需慎重选择理化指标。

（11）李新纯教授

气滞证理化指标不够明显，可操作性不强，范围广，如脑区兴奋等。中医最大的特点不是靠实验，而是观察舌脉开方治疗，常规的理化指标用于观察患者服用中药后是否会出现不良作用，因此，理化指标不一定有意义，可能对科研方面有用，但对诊断气滞证必要性不强。

（12）张涛教授

中医的气滞证与脏腑证应有共性，其次突出脏腑个性。气滞证、肝郁气滞证都是与情志密切相关，中医可以结合西医量化积分表，达到阈值后就可以评定为此证型，此方法更容易被临床接受。

（13）刘旺华教授

问卷中的理化指标与中医关联度不高，因此，文献质量要进行评估。注意总证与亚型的关系，总证是一个汇总还是共性？考虑不同病位的气滞证共性在哪里？作为科学研究，按照取象比类的思想，气滞心脉证是否可以考虑心室舒张期末直径、容积、压力？胃肠气滞通降能力下降，是否可以考虑胃动力检测指标？肺气郁滞证是否考虑红细胞计数、红细胞压积、血氧饱和度、氧合血红蛋白与还

原血红蛋白比？今后可通过大样本研究验证是否可以纳入诊断标准？

(14)简维雄教授

理化指标选择一定要慎重，尤其气滞证和亚型证更倾向于自身选择，慎重选择后对于标准更有意义。

(15)丁长松教授

诊断系统做成后，能不能做个计算机临床辅助系统，具有临床意义。量化指标分值为0、1、2、3、4，打分的间距定量范围的设置如何统一，需更深入的探索与实施。

(16)李晓娟教授

临床标准，在文献检索后，需要进行文献质量评价和信度效度判定，否则难以推广于临床。

(17)陈家旭教授

宏观指标、试验指标、文献选择专家都提了很多宝贵的意见，后续需认真总结。

(18)胡志希教授

①证型比较：专家意见集中在基础证和具体证之间的共性与个性。气滞证作为一个基础证，我们研究的气滞证诊断标准，需在基础证上根据不同部位的脏腑，分为心脉气滞证，肝郁气滞证，胃肠气滞证，肺气郁滞证四个亚型证，共五个证。据李先涛教授所说只申报了一个气滞证，团队也在考虑能不能做五个标准，气滞证及其亚型证的标准诊断，也将是本团队下一步要做的一个工作。目前证型集中在共性与个性方面，就是说气滞证的主次症应该在亚型中有体现，如同专家提出证型之间不要相互矛盾，相互冲突，所以我们将根据专家意见予以修正条目。

②理化指标：原本未涉及理化指标的内容，现代中医应该利用现代科技的东西，包括形态学的、功能性的理化指标，但没有特异性指标，实施可能比较困难。理化指标作为一个标准来颁布，需达成专家共识和标准实施是比较困难的，所以我们将会慎重考虑理化指标。

③根据郑教授所提及的意见，我们将会完成文献质量控制。关于专家涉及的量表诊断效能方面，团队将问卷修改后的内容转换成量表的形式发放至临床中，进行后续的临床验证等研究。

通过线上会议谈论，本团队将根据专家意见，完成问卷的修改，开展问卷调查。

八、网络合影

2.专家咨询线下研讨会

时 间： 2021 年 06 月 18 日 14:00-15:30

地 点： 科研楼 810 教室

主 持： 胡志希

专 家： 谢梦洲、刘旺华、简维雄、谢梦洲、李金霞、熊广华、李琳、杜佳

列席人员：方格、黄淑敏、王梓仪、杨杨、张倩、熊霞军、邱宏

2.1 介绍专家和参会人员

2.2 子课题负责人胡志希教授讲话

2.3 方格博士介绍气滞证诊断标准的研究进展

2.4 各位专家填写第二轮专家咨询结果调查表

2.5 方格博士介绍气滞证层次分析法专家咨询判断矩阵

2.6 各位专家填写第三轮德尔菲法问卷

2.7 各位专家发言

2.8 会议过程留影

2.9 根据第二轮专家线下问卷意见

删除条目的修改：

① 将胃肠气滞证中用统计学方法删除的“呕吐”和“苔薄腻”条目予以添加；

② 将心脉气滞证中用统计学方法删除的“舌质淡红”条目予以添加。

原始条目的修改：

（1）气滞证

①“胀窜满闷痛”改为“胀满（闷）、胀痛或窜痛”；

②“情志抑郁”与“急躁易怒”放次症。

（2）肝郁气滞证

①“情志抑郁”与“急躁易怒”呈“或”并列；

②删矢气、纳呆。

（3）胃肠气滞证

①“苔薄腻”改为“苔腻”；

②“情志抑郁”、“急躁易怒”放次症；

③“纳呆”放主症；

④添加的“呕吐”做次症。

（4）心脉气滞证

①“情志抑郁”与“急躁易怒”呈“或”并列，放次症；

②“失眠”、“苔薄腻”删除。

（5）肺气郁滞证

①“胸背部”改“胸部”；

②“情志抑郁”与“急躁易怒”呈“或”并列，放次症；

③“喘息上气”改为“气喘”；

④删“咽喉异物感”。